PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS

(2019- nCoV)

Jacundá– PA
Abril de 2021

COMISSÃO DE GESTÃO

Prefeito Municipal de Jacundá
Itonir Aparecido Tavares

Secretário Municipal de Saúde
Irailde Gonçalvez Bizarrias

Coordenador Do Departamento de Atenção Básica
Davidoson de Sousa Braga

Coordenadora de Vigilância em Saúde
Lícia Conceição Souza

Coordenador de Imunização
Ailton Lima

Diretor Adminsitrativo do Hospital Municipal Maria Cecília
Bruno Pinheiro Dal Col

Diretor Médico do Hospital Municipal Maria Cecília
Mayda Verdi Ferreira Nicácio

Coordenador do Programa Melhor em Casa
Thatyane Feitosa Lim

Coordenador da Farmácia Central
Débora Meireles Quaresma

1. INTRODUÇÃO

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da OMS na China foi informado sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade de Wuhan, província de Hubei. As autoridades chinesas identificaram um novo tipo de Coronavírus, que foi isolado em 07 de janeiro de 2020. Em 11 e 12 de janeiro de 2020, a OMS recebeu mais informações detalhadas, da Comissão Nacional de Saúde da China, de que o surto estava associado a exposições em um mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da disseminação do Coronavírus.

Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana da doença, por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011.

Em 26 de fevereiro 2020 O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de novo coronavírus em São Paulo. O homem de 61 anos deu entrada no Hospital Israelita Albert Einsteincom histórico de viagem para Itália, região da Lombardia. No dia 18 de março 2020 notifica-se o primeiro caso no estado do Pará e no dia 21 de abril o municipio de Jacundá teve seu primeiro caso confirmados de infecção humana por SARS-CoV-2.

O presente documento tem como objetivo apresentar aos serviços de saúde e a população as medidase condutas a serem adotadas frente aoscasos suspeito/confirmado de coronaviruas , bem como as medidas de prevenção, controle e mitigação de infecção pelo SARS- Cov-2.

As orientações aqui propostas têm como base as informações atualmente disponíveis nas Notas Técnica da Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde, Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do presente ano e podem ser redefinidas à medida que mais informações estiverem disponíveis, já que se trata de um microrganismo novo no mundo e, portanto, com poucas evidências sobre ele.

Nova CEPA

No ano 2021, Cientistas de dez instituições, entre elas o Imperial College London e a Universidade de Oxford, ambas na Inglaterra, e o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, publicaram um artigo descrevendo casos de novas variantes. A nova Cepa tem uma combinação de 18 mutações nunca anteriormente descritas no Sars-CoV-2 , mas ainda não se sabe se causa maior transmissão do vírus.

Essa caracteristica de uma nova variante faz Brasil viver escalada da doença que bateu recorde de mortes em 24 horas: foram notificados 508 óbitos. Até abril/2021, a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA destacam cinco variantes entre as mais preocupantes:
- **B.1.1.7** (detectada inicialmente no Reino Unido)
- **P.1** (conhecida como a variante de Manaus)
- **B.1.351** (África do Sul)
- **B.1.427** (Estados Unidos)
- **B.1.429** (Estados Unidos)

O Plano de Contingência, bem como orientações e ações sofreram adicionais produzidos em virtude da alteração do cenário da pandemia, considerando redobrada atenção de cuidados devido a variantes (onde as mudanças ocorreram nos genes que codificam a espícula, a estrutura que fica na superfície do vírus e permite que ele invada as células do nosso corpo, que pode deixar o coronavírus ainda mais infeccioso).

2. OBJETIVOS DO PLANO DE CONTIGÊNCIA

2.1 Objetivos Gerais

Reduzir o impacto da pandemia quanto a trasmissibilidade, morbidade e mortalidade relacionada à Covid-19 e otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação de ações adequadas e oportunas aos objetivos.

2.2 Objetivos Específicos

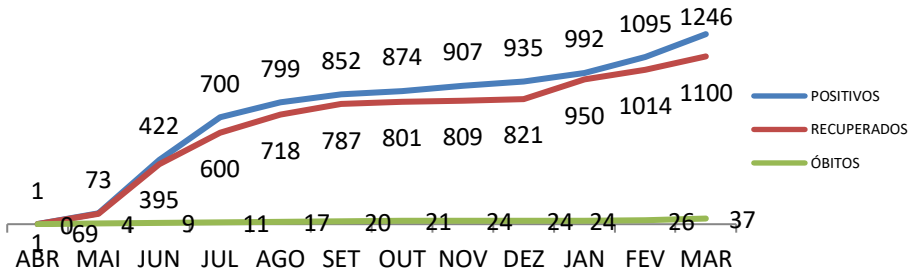
- Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos e confirmados de forma oportuna;
- Organizar o fluxo de ações de prevenção e controle do Coronavírus;
- Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e manejo clinico adequado;
- Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos e confirmados;
- Traçar estratégias para redução da transmissão da doença, por meio do monitoramento e controle dos pacientes já detectados;
- Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede municipal de saúde;
- Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada dedecisão;
- Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serão implementadas.

3. PERFIL EPIDEMIOLÓGICA DA COVID 19 NO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

Jacundá registrou seu primeiro caso de covid-19 e março de 2020. Na distribuição de casos confirmados e óbitos por mês, percebe-se que o pico da primeira onda da pandemia no município de Jacundá ocorreu em junho de 2020, atingindo estabilidade de casos e óbitos a partir de setembro/2020.

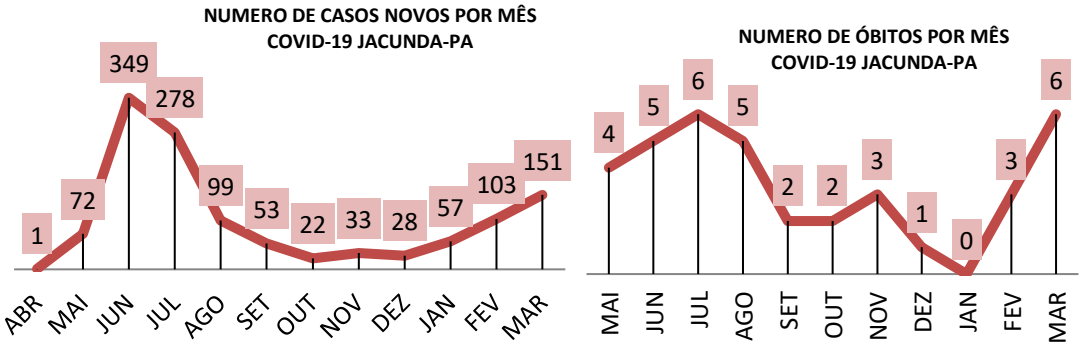
Em fevereiro de 2021, os casos voltaram a aumentar, já com reflexo da segunda onda e, possivelmente, a circulação de outras variantes importantes, conforme mostram os gráficos abiaxo:

Curva Epidêmica de Casos Recuperados, Confirmados e Óbitos por COVID-19, por mês em Jacundá, de Abril/2020 a 31/MAR/2021.



Fonte: Sistema de Monitoramento de COVID-19, Secretaria Municipal de Saúde de Jacundá.

Curva Epidêmica de número de casos e óbitos por mês em Jacundá, de 04/2020 a 03/202



Fonte: Sistema de Monitoramento de COVID-19, Secretaria Municipal de Saúde de Jacundá.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS SOBRE A INFECÇÃO HUMANA COVID-19

A transmissão do SARS-CoV-2 acontece de uma pessoa doente para outra por meio de gotículas respiratórias eliminadas ao tossir, espirrar ou falar, por meio de contato direto ou próximo, especialmente através das mãos não higienizadas e pelo contato com objetos ou superfícies contaminadas. Estudos apontam que uma pessoa infectada pelo vírus SARS-CoV-2 pode transmitir a doença durante o período sintomático, que pode ser de 2 a 14 dias, em geral de 5 dias, a partir da infecção, mas também sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Ainda há controvérsias acerca da transmissão do vírus por pessoas assintomáticas.

4.1 Definições de Casos

Definição de Caso suspeito

Situação 1: Febre* E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) **E** histórico de viagem para área com transmissão local**, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais.

OU Situação 2: Febre* **E** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) **E** histórico de contato próximo*** de caso suspeito para o coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ousintomas;

OU Situação 3: Febre* **OU** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) **E** contato próximo de caso confirmado de coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ousintomas.

- **Caso provável**

Caso suspeito com o teste inconclusivo para 2019-nCoV ou com teste positivo em ensaio de pan-coronavírus.

- **Caso confirmado**

Indivíduo com confirmação laboratorial para 2019-nCoV, independente de sinais esintomas.

- **Caso descartado**

Caso suspeito com resultado laboratorial negativo para 2019-nCoV ou confirmação laboratorial para outro agenteetiológico.

SINAIS E SINTOMAS Geralmente, o paciente com COVID-19 apresenta quadro de síndrome gripal (SG), podendo evoluir para síndrome respiratória aguda grave (SRAG). No quadro a seguir estão dispostos os sinais e sintomas por classificação:

Classificação dos sinais e sintomas por grupo	Leve	Moderado	Grave
Adulto e Gestante	Síndrome gripal: tosse, dor de garganta ou coriza seguido ou não de: – Anosmia (disfunção olfativa) – Ageusia (disfunção gustatória) – Coriza – Diarreia – Dor abdominal – Febre – Calafrios – Mialgia – Fadiga – Cefaleia	- Tosse persistente + febre persistente diária **OU** - Tosse persistente + piora progressiva de outro sintoma relacionado à COVID-19 (adinamia, prostração, hiporexia, diarreia) **OU** - Pelo menos um dos sintomas acima + presença de fat de risco	Síndrome respiratória aguda grave – síndrome gripal que apresente: Dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no tórax OU Saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU Coloração azulada de lábios ou rosto *Importante: em gestantes, observar hipotensão.
Crianças			– Taquipneia: ≥ 70 rpm para menores do que 1 ano; ≥ 50 rpm para crianças maiores do que 1 ano; – Hipoxemia; – Desconforto respiratório; – Alteração da consciência; – Desidratação; – Dificuldade para se alimentar; – Lesão miocárdica; – Elevação de enzimas hepáticas – Disfunção da coagulação; rabdomiólise; – Qualquer outra manifestação de lesão em órgãos vita

Condições e fatores de risco a serem considerados para possíveis complicações da síndrome gripal:

- Idade igual ou superior a 60 anos;
- Miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica etc.);
- Hipertensão;
- Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC);
- Tabagismo;
- Obesidade;
- Imunodepressão;
- Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
- Diabetes mellitus, conforme juízo clínico;
- Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
- Neoplasia maligna;
- Gestação de alto risco

5. DIAGNÓSTICO

5.1 Diagnóstico Laboratorial

O diagnóstico laboratorial pode ser realizado tanto por testes de biologia molecular, sorologia ou testes rápidos.

- **Biologia molecular**: permite identificar a presença do material genético (RNA) do material genético (RNA) do vírus SARS-CoV-2 em amostras de secreção respiratória, por meio das metodologias de RT-PCR em tempo real (RT-qPCR) e amplificação isotérmica mediada por loop com transcriptase reversa (reverse transcriptase loop-mediated isothermal amplification, RT-LAMP).

- **Sorologia**: detecta anticorpos IgM, IgA e/ou IgG produzidos pela resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV-2, podendo diagnosticar doença ativa ou pregressa. As principais metodologias são: Ensaio Imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – Elisa), Imunoensaio por Quimioluminescência (Clia) e Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (Eclia).

- **Testes rápidos**: Estão disponíveis dois tipos de testes rápidos, de antígeno e de anticorpo, por meio da metodologia de imunocromatografia. O teste rápido de antígeno detecta proteína do vírus em amostras coletadas de naso/orofaringe, devendo ser realizado na infecção ativa (fase aguda) e o teste rápido de anticorpos detecta IgM e IgG (fase convalescente), em amostras de sangue total, soro ou plasma. Fluco de testagem anexa (Anexo 02)

5.2 Diagnóstico por Imagem

Imagem (tomografia computadorizada de alta resolução – TCAR): As seguintes alterações tomográficas são compatíveis com caso da covid-19:

- OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”). z OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis

("pavimentação").

- SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em organização (observados posteriormente na doença).

6. REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)

É imprescindível a estruturação da rede de arenção à saúde para o atendimento adequado dos casos suspeitos ou confirmados da covid-19. Faz-se necessário estabelecer o fluxo de atendimento para o acesso aos serviços de saúde, de forma a direcionar os pacientes à "porta de entrada" adequada do Sistema único de Saúde (SUS), diminuindo a propagação do vírus e a possibilidade de infecção entre os pacientes e profissionais e/ou pacientes e pacientes, na Rede de Atenção à Saúde (RAS) através do trabalho sistêmico, organizado e uniforme durante a fase epidêmica do COVID19. Identificar, mapear e garantir o atendimento e manejo clínico adequado aos pacientes com Síndrome Gripal, isolados ou não, Síndrome Respiratória Aguda Grave, pacientes POSITIVOS e CONTATOS DE PACIENTES POSITIVOS para COVID-19 nos diferentes níveis de infecção.

A RAS de Jacundá conta:

- 10 equipes de saúde da família, 02 postos de saúde na Zona Rural, na Atenção Primária (Fluxograma de atendimento Anexo 01
- 01 Hospital com Anexo de leitos de isolamento exclusivo para casos sintomaticos da COVID 19, (no prédio da rua Jatobal)
- 01 SAMU
- 01 Laboratório Municipal
- 01 Serviço de Atendimento Domiciliar
- 01 Ponto de Teleatendimento para consultas com especialistas
- 01 CAPS
- 01 Farmácia Central

SITUAÇÃO 01: DEMANDA ESPONTÂNEA

Pacientes que procurarem atendimento voluntariamente, sem avaliação médica prévia, no hospital geral (demanda espontânea), poderão ser atendidos pela equipe do plantão, que dará o direcionamento clínico e terapêutico adequado e garantirá o cumprimento dos protocolos de tratamento/isolamento/monitoramento podendo referenciar este paciente ao hospital de campanha ou para acompanhamento posterior na unidade de saúde. Ressalta-se que isso seja feito somente nas situações excepcionais, em que não conseguir atendimento nas unidades de saúde (nos finais de semana e feriados, por exemplo).

SITUAÇÃO 02: PACIENTE COM SINTOMAS GRIPAIS (SUSPEITO) QUE AINDA NÃO RECEBEU ATENDIMENTO MÉDICO

Pacientes que apresentem sintomas gripais e ainda não tenham passado por avaliação de profissional de saúde devem PROCURAR ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA DA SUA CASA, que é uma das portas de entrada do SUS.Na unidade, este paciente SERÁ avaliado por profissional de saúde MÉDICO ou ENFERMEIRO, conforme as atribuições definidas por Lei de exercício de cada profissão. Este profissional, definirá a conduta a ser adotada, após a avaliação clínica, considerando os sintomas clínicos que evidenciam ou descartam Síndrome Gripal – SG (febre >= 38ºC -> aferida ou referida + tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta), conforme o Protocolo de Manejo Clínico do Novo Corona Vírus-COVID-19 (Ministério da Saúde,

2020). O diagnóstico sindrômico depende da investigação clínico-epidemiológica e do exame físico. Conduta uniforme é sugerida para todos os casos de SG no contexto da APS/ESF, dada a impossibilidade de atestar com 100% de segurança se a SG é causada pelo SARS-CoV-2 ou por outro vírus. Todos os pacientes diagnosticados com Síndrome Gripal, que não necessitem de atendimento de urgência médica ou hospitalar, devem ser orientados a cumprirem isolamento domiciliar por 14 dias (a contar do início dos sintomas), juntamente com todos os seus contatos intradomiciliares, inclusive os assintomáticos. O profissional responsável pelo atendimento deverá preencher um TERMO DE ISOLAMENTO com os dados do paciente sintomático e seus contatos intradomiciliares, que deverá ser assinado pelo paciente, assumindo este o compromisso de cumprir a medida de isolamento. A partir deste momento, a equipe da ESF realizará o monitoramento dos sintomas de todos os isolados(preferencialmente por telefone, ou presencial, quando for necessário), duranteo período definido no TERMO. A equipe de monitoramento acompanhará a evolução clínica dos pacientes e, juntamente com o médico e enfermeiro da unidade definirão as condutas posteriores a serem adotadas, a citar: atendimento médico na própria unidade; atendimento médico hospitalar, teste rápido, liberação de isolamento.

SITUAÇÃO 03: PACIENTES SINTOMÁTICOS GRIPAIS (SUSPEITOS) EM ISOLAMENTO DOMICILIAR, SEM DIAGNÓSTICO POSITIVO DE COVID-19

Pacientes que já estejam em isolamento domiciliar por síndrome gripal e também os seus contatos, sem diagnóstico confirmado de COVID-19, caso precisem de atendimento médico, deverão ser direcionados pela equipe de monitoramento para avaliação na unidade de saúde mais próxima. O médico da unidade, após avaliação clínica ambulatorial, definirá a conduta terapêutica mais adequada, a citar: atendimento
hospitalar; medicação; retorno ao monitoramento.

SITUAÇÃO 04: PACIENTES COM DIAGNÓSTICO POSITIVO DE COVID-19 E SEUS CONTATOS INTRADOMICILIARES QUE JÁ ESTEJAM EM ISOLAMENTO DOMICILIAR

Pacientes já positivados ou seus contatos intradomiciliares comumente isolados, sintomáticos ou não, que necessitem de atendimento médico, deverãoser direcionados para o centro de atendimento para covid para avaliação médica e conduta terapêutica adequada. não deve ser recomendado a pacientes com este perfil que sejam atendidos na unidade de saúde e nem no hospital municipal (hoje funcionando no prédio do Hospital Samaritano), face ao risco de contaminação que os mesmos oferecem.

SITUAÇÃO 05: PACIENTES CONTATOS PRÓXIMOS DE PACIENTES POSITIVOS PARA COVID-19

Pacientes com este perfil, Se assintomáticos, deverão procurar orientação na unidade de saúde mais próxima, podendo cumprir medida cautelar de QUARENTENA, conforme avaliação clínica epidemiológica do grau e das circunstâncias do contato.Se sintomáticos, deverão procurar a unidade de saúde mais próxima, seguindo as mesmas orientações descritas na “SITUAÇÃO 1”.

NOTA: É de suma importância que a assistência farmacêutica do município garanta o acesso aos medicamentos para o tratamento dos sintomáticos, mediante conduta e prescrição médica, sem infringir as restrições de mobilidade impostas pelo risco de contaminação que estes pacientes oferecem para o restante da população. Não recomendamos que pacientes suspeitos e/ou sintomáticos quebrem o isolamento domiciliar recomendado, após diagnóstico médico, sob a prerrogativa de que fizeram isso em busca de medicamento. É um contra censo! Assim sendo, recomendamos que seja garantido ao paciente o acesso à medicação no ato do diagnóstico e que sejam estudadas as medidas legais para isso, haja vista o prejuízo indiscutível à integralidade do

cuidado que a dificuldade do acesso à medicação acarreta.
Abaixo, os serviços disponíveis e suas características:

Tipo de serviço	Público demandante: sinais/sintomas	Procedimentos possíveis	Exames possíveis de imediato	Profissionais necessários	Desfechos esperados
Atenção Primária à Saúde	Leves Moderados graves	Acolhimento(*), primeiro atendimento e diagnóstico clínico(**), suporte terapêutico e ventilatório (se disponível)	Testagem (se disponível), oximetria (se disponível), exames de sangue (se disponível), exames complementares (se disponível e se necessário)	Médico, enfermeiro, téc. de enfermagem, agente comunitário de saúde, equipe de saúde bucal, equipe multidisciplinar	Orientação para tratamento domiciliar, acompanhamento domiciliar ou encaminhamento para estabelecimento de saúde de média ou alta complexidade
Programa Melhor em Casa/ Serviços de Atenção Domiciliar (SAD)	Leves Moderados graves	Atendimento domiciliar e diagnóstico clínico(**), suporte terapêutico e ventilatório (se disponível)	Testagem (se disponível), oximetria (se disponível), coleta de exames de sangue,encaminhamento para outros exames complementares (se necessário)	Médico, enfermeiro, téc. de enfermagem e fisioterapeuta + equipe multiprofissional	Alta de acompanhamento domiciliar ou encaminhamento paraestabelecimento de saúde de média ou alta complexidade
Hospital de pequeno porte	Leves Moderados graves	Acolhimento(*) e primeiro atendimento e diagnóstico clínico(**), suporte terapêutico e ventilatório	Testagem, exames de sangue e radiografias	Médico, enfermeiro, téc. enfermagem e fisioterapeuta	Alta para acompanhamento domiciliar, internação de casos moderados **OU** encaminhamento para estabelecimento de saúde de alta complexidade
Unidade de Atendiemento pacietnes com SG e SRAG	moderados graves	Acolhimento(*) e primeiro atendimento e diagnóstico clínico(**), suporte terapêutico e ventilatório	Testagem, exames de sangue e radiografias	Médico, enfermeiro, téc. enfermagem e fisioterapeuta	Alta para acompanhamento domiciliar, internação de casos moderados **OU** encaminhamento para estabelecimento de saúde de alta complexidade
Hospital de referência	Graves e muito graves	Acolhimento(*) e primeiro atendimento e diagnóstico clínico(**), suporte terapêutico e ventilatório, UTI especializada	Testagem, exames laboratoriais, radiografias, exames de imagem e outros	Médico, enfermeiro, téc. de enfermagem e fisioterapeuta + equipe multiprofissional	Alta para acompanhamento domiciliar OU internação ou transferência para serviço menos complexo OU hospital de referência

Melhor em Casa/ Serviços de Atenção Domiciliar (SAD): Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e de Apoio (EMAD). Vide Nota Técnica nº 9, sobre recomendações da Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar em relação à atuação dos SAD/ Programa Melhor em Casa na pandemia do coronavírus (COVID-19). Disponível em: portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/20/doc-nota-tecnica-covid19

(*) Acolhimento do paciente com sintomas gripais **em todos os serviços:**

- Fluxo diferenciado sinalizado;
- Os pacientes com sintomas respiratórios deverão utilizar máscaras conforme protocolo local;
- Fornecer meios para higienização das mãos;
- Sala de espera exclusiva.

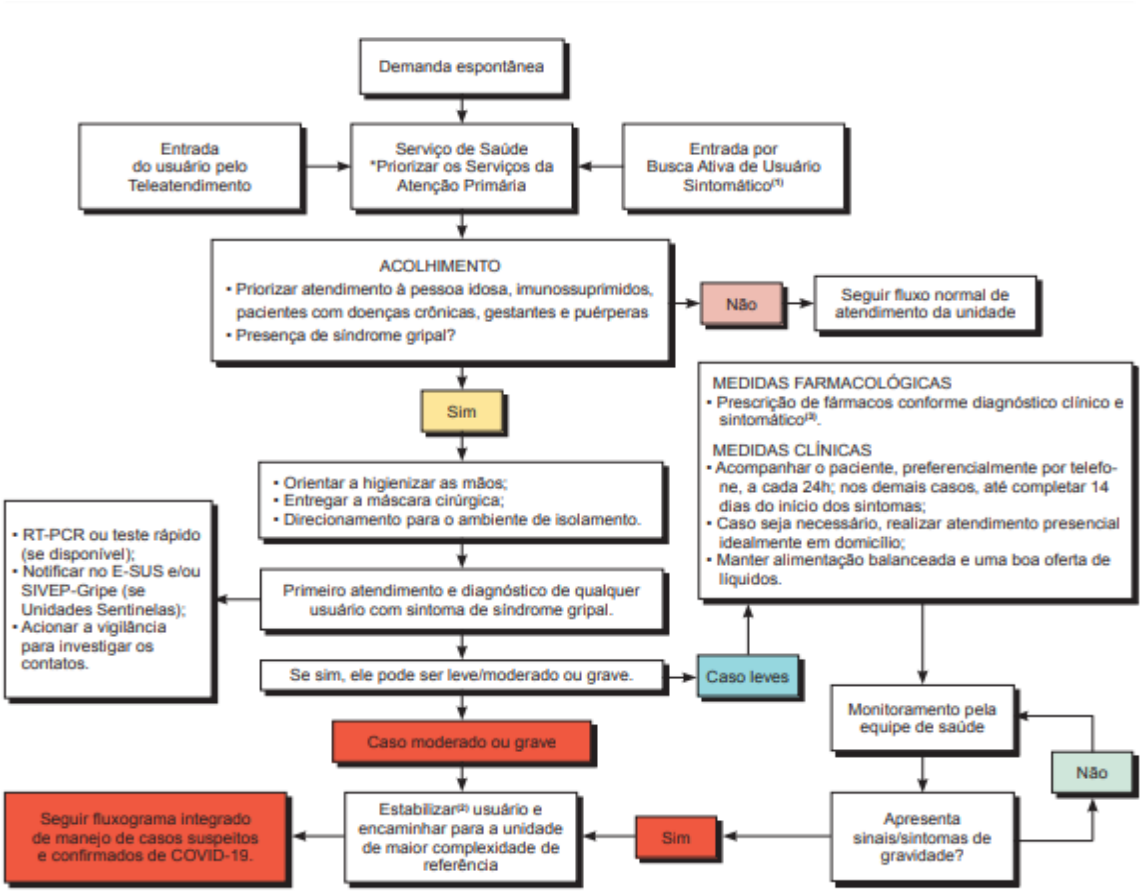
(**) Primeiro atendimento para diagnóstico clínico **em todos os serviços:**

● Atendimento seguindo as recomendações de precaução de contato e respiratório (gotículas, aerossóis ou em caso de procedimentos que gerem aerossóis);
● Coletar informações sobre a história pregressa e antecedentes de risco do paciente;
● Realizar exame físico, obter dados vitais, oximetria de pulso;
● Realizar o diagnóstico clínico;
● Avaliar a necessidade de testagem para COVID-19;
●Avaliar necessidade de solicitar exames de sangue (hemograma, coagulograma, função hepática e renal,ionograma, LDH, PCR, D-Dímero e gasometria se saturação O2 < 95%);
● Avaliar necessidade de exames de imagem e exames complementares: radiografia ou tomografia
computadorizada (TC) de tórax e eletrocardiograma;
● Realizar prescrição de acordo com o quadro clínico do paciente;
● Encaminhar para alta e monitoramento domiciliar ou serviço de maior complexidade, conforme diagnóstico.

Nota: A unidade de internação para SG E SRAG anexo ao Hosital Municipal Maria Cecília não atenderá demanda espontânea de pacientes, por ser uma unidade de referência para pacientes sintomáticos e suspeitos de Covid-19 que precisem de atendimento, internação e cuidados hospitalares. Os pacientes que necessitem de avaliação médica indiscriminada, procurar outros pontos de atendimento da secretaria municipal de saúde, rede de atenção à saúde, conforme as situações abaixo descritas.

O reconhecimento precoce de sinais e sintomas da doença e monitoramento contínuo dos pacientes permitem maior resposta à infecção. Considerando as características gerais da infecção, as manifestações clínicas e as possíveis complicações, e com o objetivo de orientar a conduta terapêutica adequada a cada caso, foram elaborados, pelo Ministério da Saúde, documentos técnicos contendo orientações quando ao manejo clínico e tratamento de pacientes com covid-19, disponíveis no link: https://coronavirus. saude.gov.br/manejo-clinico-e-tratamento.

FLUXOGRAMA PARA CONDUTA CLÍNICA CONFORME QUADRO DO PACIENTE



(1) Entrada por Busca Ativa: usuários que foram orientados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) ou outros profissionais de saúde a procurarem as unidades atenção da primária. Os ACS são atores importantes na identificação precoce dos casos de síndrome gripal na comunidade. (2) Caso o atendimento ocorra na APS, estabilizar o usuário para transporte: garantir estabilidade ventilatória e hemodinâmica, se necessário fornecendo cateter com O2 e soro endovenoso. (3) Nota Informativa nº 9/2020 GAB/SE/MS: Orientações para Manuseio Medicamentoso Precoce de Pacientes Adultos com Diagnóstico de COVID-19 e suas atualizações.

7. REGULAÇÃO

Todo caso confirmado que apresentar sinais de agravamento deverá ser regulado para o hospital de referência (Hospital Regional de Marabá). **Vaga zero** somente em caso especial.

7. VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENFRENTAMETO À COVID-19

A Vigilância à Saúde desempenha um papel fundamental no acompanhamento e no fornecimento de informações para o manejo das epidemias, bem como fscalizar e orientar os estabelecimentos que estão em funcionamento, averiguando sempre se há condições sanitárias para o funcionamento.

Nesse âmbito, destaca-se a Vigilância Epidemiológica, Sanitária de Saúde do Trabalhador.

7.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Atividades desenvolvidas no contexto da pandemia:

7.1.1NOTIFICAÇÃO

A Doença pelo SARS-CoV-2 (COVID-19) é uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), do Regulamento Sanitário Internacional. Portanto, trata-se de um evento de saúde pública de notificação imediata. A fim de proceder com a adequada notificação do evento, seguir as orientações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde no Guia de Vigilância Epidemiológica que se encontra disponível no: no Portal do Ministério da Saúde. Além da notificação, as informações de todos pacientes com síndrome gripal devem ser registradas no prontuário para possibilitar a longitudinalidade e a coordenação do cuidado, assim como realizar a eventual investigação epidemiológica e posterior formulação de políticas e estratégias de saúde.

Atente para o uso do CID-10 correto sempre que disponível no sistema de registro. O CID-10 que deve ser utilizado para síndrome gripal inespecífica é o J11.
Os CID-10 específicos para infecção por coronavírus são o B34.2 - Infecção por coronavírus de localização não especificada, e os novos códigos U07.1 - COVID-19, vírus identificado e U07.2 - COVID-19, vírus não identificado, clínico epidemiológico, que são os marcadores da pandemia no Brasil.

Notificação e registro municipal

Nas unidades públicas (Atenção Primária e pronto atendimento) e unidades privadas (clínicas, consultórios etc.) casos de **Sindrome Gripal** devem ser notificados através de ficha especifica (anexo1) sendo também preenchido termo de isolamento domiciliar com descrição dos contatos domiciliares que consta no referido termo(anexo2). A vigilância por meio do sistema e-SUS VE **www.notifica.saude.gov.br**) realizará a informação após recebimento da refererida ficha e termo em tempo oportuno.

Além do prenchimento as unidades de saúde devem monitorar e acompanhar casos suspeitos, confirmados e seus contatos para em tempo oprtuno tomar medidas precoces e evitar complicações futuras a saúde do paciente e coletividade.

caso de SRAG hospitalizado e óbito por SRAG devem ser notificados imediatamente e informado a vigilância o mais breve possível para que seja acionado o serviço de coleta de material para exame laboratorial da amostra. A vigilância deve informar a notificação no Sivep e cadstrar a amostra que será enviada para análise (LACEN) no gal.

*NÃO ESTÁ INDICADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ASSINTOMÁTICOS.

7.1.2 ISOLAMENTO

Para contenção da transmissibilidade do COVID-19, deverá ser adotada como medida não farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, conforme abaixo:

Orientações para inclusao de indivíduos no isolamento

a) Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19:recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após 10 dias do início dos sintomas, desde que

passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.

b) Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínicolaboratorial) para COVID-19:

recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após 20 dias do início dos sintomas OU após 10 dias com resultado RT-qPCR negativo, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.

a) Para indivíduos com quadro de SG para os quais não foi possível a confirmação pelos critérios clínico, clínico epidemiológico ou clínico imagem, que apresentem resultado de exame laboratorial não reagente ou não detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2:

o isolamento poderá ser suspenso, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.

b) Para indivíduos hospitalizados com quadro de SRAG para os quais não foi possível a confirmação pelos critérios clínico, clínico epidemiológico ou clínico imagem, caso um primeiro teste de RT-qPCR venha com resultado negativo, um segundo teste na mesma metodologia, preferencialmente com material de via aérea baixa, deve ser realizado 48 horas após o primeiro.

Sendo os dois negativos, o paciente poderá ser retirado da precaução para COVID-19 (atentar para o diagnóstico de outros vírus respiratórios, como influenza).
Ao receber alta hospitalar antes do período de 20 dias, o paciente deve cumprir o restante do período em isolamento OU após 10 dias com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.
c) Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 (resultado detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-C oV-2), deve-se manter isolamento, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta da amostra.

OBSERVAÇÕES:

- Testes sorológicos (teste rápido, ELISA, ECLIA, CLIA) para COVID-19 não deverão ser utilizados, de forma isolada, para estabelecer a presença ou ausência da infecção pelo SARSCoV-2, nem como critério para isolamento ou sua suspensão, independentemente do tipo de imunoglobulina (IgA, IgM ou IgG) identificada.
- Para casos confirmados de COVID-19 em indivíduos severamente imunocomprometidos, a estratégia baseada em testagem laboratorial (RT-qPCR) deve ser considerada, a critério médico, para descontinuidade do isolamento.
- Os casos encaminhados para isolamento deverão continuar usando máscara e manter a etiqueta respiratória, sempre que for manter contato com outros moradores da residência, mesmo adotando o distanciamento social recomendado de pelo menos um metro.
- Neste período, também é importante orientar ao caso em isolamento, a limpeza e desinfecção das superfícies, conforme as recomendações da Anvisa.

Orientações acerca das condições estruturais para isolamento

a. O isolamento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) deve ser realizado, preferencialmente, em quarto privativo com porta fechada e bem ventilado (ou outro local apropriado).
b. Os profissionais de saúde que atuarem na assistência direta aos casos suspeitos ou confirmados devem ser organizados para trabalharem somente na área de isolamento, evitando circulação para outras áreas de assistência.
c. A área estabelecida como isolamento deverá ser devidamente sinalizada, inclusive quanto às medidas de precaução a serem adotadas: padrão, gotículas e contato ou aerossóis.

Isolamento em quarto privativo (ou outro local apropriado)

- O isolamento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) deve ser realizado, preferencialmente em um quarto privativo com porta fechada e bem ventilado.
- A unidade deverá manter o paciente isolado até que seja liberada a vaga no HC- UFU através da Regulação, ou vaga zero (esse caso será avaliado)

Isolamento por coorte

- Considerando a possibilidade de aumento do número de casos, se o hospital não possuir quartos privativos disponíveis em número suficiente para atendimento de todos os casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV), deve ser estabelecido o isolamento por coorte, ou seja, separar em uma mesma enfermaria ou área os pacientes com infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV).
- É fundamental que seja mantida uma distância mínima de 1 metro entre os leitos dos pacientes.
- Restringir ao máximo o número de acessos a esta área, inclusive visitantes, com o objetivo de se conseguir um maior controle da movimentação de pessoas, evitando-se o tráfego indesejado e o cruzamento desnecessário de pessoas e serviços diferenciados.
- Os profissionais de saúde que atuam na assistência direta aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) devem ser organizados para trabalharem somente na área de isolamento não devendo circular para outras áreas de assistência.

Orientações adicionais

- Os serviços de saúde devem manter um registro de todas as pessoas que prestaram assistência direta ou entram nos quartos ou na área de assistência desses pacientes. O quarto, enfermaria ou área de isolamento deve ter a entrada sinalizada com alerta referindo ISOLAMENTO, a fim de evitar a passagem de pacientes e visitantes de outras áreas ou de profissionais que estejam trabalhando em outros locais do serviço de saúde. O acesso deve ser restrito aos profissionais envolvidos na assistência direta ao paciente.
- O quarto (ou outro local apropriado) também deve estar sinalizado quanto às medidas de precaução a serem adotadas: padrão, gotículas e contato ou aerossóis (em condições específicas).
- Imediatamente antes da entrada do quarto, enfermaria ou área de isolamento deve ser disponibilizada: Condições para higiene das mãos: dispensador de preparação alcoólica (gel ou solução a 70%), lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha,

papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual.

- EPI apropriado, conforme já descrito neste documento.
- Mobiliário para guarda de EPI.
- Os serviços de saúde devem elaborar, disponibilizar de forma escrita e manter disponíveis, normas e rotinas dos procedimentos envolvidos na assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV), tais como: fluxo dos pacientes dentro do serviço de saúde, procedimentos de colocação e retirada de EPI, procedimentos de remoção e processamento de roupas/artigos e produtos utilizados na assistência, rotinas de limpeza e desinfecção de superfícies, rotinas para remoção dos resíduos, entre outros.
- Deve ser restringida a entrada de acompanhantes/ visitantes com doença respiratória aguda.
- Deve ser restringida a atuação de profissionais da saúde com doença respiratória aguda.
- Pacientes e visitantes devem ser orientados a minimizar o risco de transmissão da doença, adotando ações já descritas neste documento.
- Sempre que possível, equipamentos, produtos para saúde ou artigos utilizados na aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) devem ser de uso exclusivo, como no caso de estetoscópios, esfigmomanômetro e termômetros. Caso não seja possível o seu uso exclusivo, todos os produtos utilizados nestes pacientes devem ser limpos e desinfetados ou esterilizados antes de serem utilizados em outros pacientes.
- Os pacientes devem ser orientados a não compartilhar pratos, copos, talheres, toalhas, roupas de cama ou outros itens com outras pessoas.

7.2 MONOTORAMENTO

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas adequadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial esgotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância e da assistência, a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da população em tempo oportuno e visando ampliar a identificação e monitoramento de casos de Covid-19 e seus contatos, por meio de ações integradas da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Vigilância em Saúde (VS o município de Jacundá resolve intensifica as ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19.

O serviço de saúde deve realizar a busca ativa de contatos próximos (familiares, colegas de trabalho, entre outros, conforme investigação) devendo ser orientados, sob a possibilidade de manifestação de sintomas e da necessidade de permanecer em afastamento temporário em domicílio, mantendo distância dos demais familiares, além de evitar o compartilhamento de utensílios domésticos e pessoais, até que seja descartada a suspeita.

- Orientar que indivíduos próximos que manifestarem sintomas procurem imediatamente o serviço de saúde e comunicar a Vigep para que esta possa auxiliar a equipe nas condutas e monitorar os contatos.

- Considera-se pessoa com sintomas respiratórios, a apresentação de tosse seca, dor de garganta, ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre.

- As pessoas com mais de 60 anos de idade, devem observar o distanciamento social, restringindo seus deslocamentos para realização de atividades estritamente necessárias,

evitando transporte de utilização coletiva, viagens e eventos esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas.

7.3 IMUNIZAÇÃO COMO PRINCIPAL ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO À COVID-19

Entende que a imunização é uma das ações mais importantes em relação ao enfrentamento à Covid-19, e que deve ser garantida a população de forma célere, equânime e de qualidade. Foi realizado em Março de 2021 o Plano Muicipal de Imunização contra Covid-19 (cópia anexa).

7.3.1 ESTRATÉGIAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA ACOVID-19

A estratégia municipal de imunização contra a covid-19 será realizada em etapas, respeitando a ordem de vacinação dos grupos definidos pelo PNI, sendo que serão priorizados os grupos de maior risco para o desenvolvimento de formas graves da doença e risco de óbitos (profissionais de saúde, idosos, idosos institucionalizados, portadores de comorbidades como hipertensão, diabetes melitos, dentre outros) e grupos com elevado grau de vulnerabilidade social e econômica (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, população privada deliberdade).

Meta / Grupos Prioritários por Fase

A meta é vacinar, pelo menos, 95% do público-alvo contra a COVID 19, **em duas doses**, com intervalo definido pelo fabricante da vacina, de acordo com as fases a seguir:

PLANO JACUDAENSE DE IMUNIZAÇÃO - GRUPOS PRIORITÁRIOS POR FASE (ATUALIZADA EM 31/03/2021)

FASES DA CAMPANHA	GRUPO PRIORIZADO	Definição	Recomendações de exigência
1ª FASE	Trabalhadores de Saúde (40%).	Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais onde são atendidos pacientes com Síndrome Gripal, seja em urgências, enfermarias ou unidades de tratamento intensivo, inclusive, funcionários que não atuem diretamente na assistencia, mas frequntam tais ambientes, como auxiliares de serviços gerais, copeiros, administrativos, entre outros. Estima-se que este grupo represente cerca de 40% dos trabalhadores de saúde.	Carteira de identificação profissional ou carteira de trabalho com a devida função e local de trabalho registrada e declaração de vínculo expedida pelo local de trabalho que comprove a atuação do profissional em assistência direta a pacientes com Síndrome Gripal.
	Pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência.	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI
	Indígenas aldeados	Indígenas aldeados (ou seja, que residam em áreas indígenas) com 18 anos ou mais atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.	A vacinação será realizada em conformidade com a organização dos Distritos Sanitários Especiais Indígena (DSEI) nos diferentes municípios.
	Pessoas com Deficiência Institucionalizadas.	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI
2ª FASE	Trabalhadores de Saúde (60%)	Trabalhadores dos serviços de Saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilânicia à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Compreende tanto os profissionais da saúde (ex. enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus espectivos técnicos e auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (ex. recepcionistas, seguranças rabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulância outros), ou seja, todos aqueles que trabalham no serviço de saúde. Incluindo-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (ex.cuidadores de idosos, dulas/parteiras), bem como do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios.	Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saude ou apresnetação de declaração emitida pelo serviço de saúde.
	Pessoas de 90 anos ou mais	Deverão receber a vacina COVID-19 em conformidade com as fases predefinidas	Documento original com foto que comprove a idade
	Pessoas de 80 a 89 anos ou mais		
	Pessoas de 75 a 79 anos		
	Pessoas de 70 a 74 anos		
	Pessoas de 65 a 69 anos		
	Pessoas de 60 a 64 anos		
	Povos e comunidades tradicionais quilombolas.	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI

	Setores operacionais e grupos especiais da Segurança Pública	Profissionais de saúde do quadro da Segurança Pública, resgate, salvamento e destaques de apoio logístico de insumos e pacientes, como o Grupamento Aéreo e Fluvial e policiais penais e agentes penitenciários que tenham contato com a população privada de liberdade. Outros grupos da Segurança Pública poderão ser convocados à vacinação no caso de decreto de lockdown em sua região de atuação. Destaca -se a importância deste grupo nas ações de saúde , inclusive no combate à pandemia, como transporte de insumos, pacientes e resgate em áreas de difícil acesso; e, durante vigência de lockdown, a necessidade de manter a segurança pública em pleno funcionamento para fiscalização e cumprimento das medidas de isolamento social.	Documento que comprove a vinculação ativa com o serviço de forças de segurança e salvamento ou apresentação de declaração emitida pelo serviço em que atua, além da necessidade constar em planilha enviada pelas chefias das forças aos municípios onde conste minimamente: nome, CPF, lotação e justificativa clara para vacinação.
3ª FASE	**Pessoas com comorbidades - Pessoas com 18 a 59 anos com uma ou mais das comorbidades**		
	Diabetes melitus	Qualquer indivíduo com diabete	Indivíduos pertencentes a esses grupos serão pré-cadastrados no SIPNI, aqueles que não tiverem sido pré- cadastrados devem apresentar atestado médico especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação.
	Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).	
	Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti---hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.	
	Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão alvo (LOA) ou comorbidade.	
	Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão alvo (LOA) e/ou comorbidade.	
	Insuficiência cardíaca (IC)	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association	
	Cor-pulmonale e pulmonar	Cor-pulmonale pulmonar primária ou secundária	
	Cardiopatia hipertensiva	ardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo)	
	Síndromes coronarianas	coronarianas (Angina Pectoris estável cardiopatia isquemica, pós Infarto Agudo do Miocárdio outras)	
	Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras)	
	Miocardiopatias e Pericardiopatias	Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericarditecrônica; cardiopatia reumática	
	Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas	Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos	
	Arritmias cardíacas	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras)	
	Cardiopatias congênita no adulto	Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.	
	Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)	
	Doença cerebrovascular	Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular	
	Doença renal crônica	Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica.	

	Imunossuprimidos	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4 <350 células/mm3; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.	
	Anemia falciforme	Anemia falciforme	
	Obesidade mórbida	Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40	
	Síndrome de down	Trissomia do cromossomo 21	
	Cirrose hepática	Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C	
4ª FASE	Profissionais da Segurança Pública na ativa.	Servidores das polícias federal, militar e civil; servidores do Centro de Perícias Científicas; bombeiros militares; policiais penais e agentes do DETRAN.	Documento que comprove a vinculação ativa com o serviço de forças de segurança e salvamento ou apresentação de declaração emitida pelo serviço em que atua
	Trabalhadores da Educação	Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e do ensino superior.	Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do profissional com a escola ou apresentação de declaração emitida pela escola.
	Forças Armadas	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI
	Pessoas em de rua	Considera-se pessoas em condição de rua o grupo populacional geterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite ou como moradia provisória, definido no art. 1o do decretono 7.053, de 23 de dezembro de 2009.	Autodeclarada e aquelas que se encontram em unidades de acolhimento para pernoite ou como moradia provisória.
	Funcionários do sistema de privação de liberdade	Demais funcionários do sistema de privação de liberdade que não tenham sido contemplados nas fases anteriores.	O planejamento e operacionalização da vacinação nos estabelecimentos penais.
	População privada de liberdade.	População acima de 18 anos em estabelecimentos de privação de liberdade	O planejamento e operacionalização da vacinação nos estabelecimentos penais deverão ser articulados com as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP)
	Pessoas com deficiência permanente severa.	1- Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas. 2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir (se utiliza aparelho auditivo esta avaliação deverá ser feita em uso do aparelho). 3- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar (se utiliza óculos ou lentes de contato, esta avaliação deverá ser feita com o uso dos óculos ou lente). 4- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.	Avacinaçao deverá ser realizada por meio de estratégias específicas, de acordo com as normas do M.S. a serem planejadas a nível municipal, sendo validada antes pela SESPA.
5º FASE	Trabalhadores de Transporte Coletivo de Passageiros Urbano e de Longo Curso	Motoristas e cobradores de transporte coletivo de passageiros.	Nessa estratégia será solicitado documento que comprove o exercício efetivo da funcão de motorista profissional do transporte de passageiros.
	Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário	Funcionários das empresas metroferroviárias de passageiros e de cargas.	Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a situaçao de trabalhador vinculado a empresas metroferroviárias de passageiros e de cargas
	Trabalhadores de Transporte aéreo	Funcionários das companhias aéreas nacionais, definidos pelo Decreto no 1.232/1962 e pela Lei no 13.475/2017.	Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a situaçao do trabalhado vinculado a companhias aéras nacionais
	Trabalhadores de Transporte Aquaviário	Funcionáris das empresas brasileiras de navegação.	Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a situaçao do trabalhado vinculado a empresa bresileira de navegação

	Caminhoneiros	Motorista de transporte de rodoviário de cargas definido no art. 1o, II da Lei no 13.103, de 2 de de 2015, que trata da regulamentação da profissão de motorista.	Nessa estratégia será solicitado documento que comprove o vínculo efetivo da funcão de motorista profissional do transporte de cargas (caminhoneiro).
	Trabalhadores Portuários	Qualquer trabalhador portuário incluindo os funcionários da área administrativa.	Nessa estratégia será solicitado documento que comprove o exercício efetivo da duncão de trabalhador.
	Trabalhadores Industriais	Trabalhadores da indústria e construção civil, conforme Decreto 10.292/2020 e 10.342/2020.	Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a situaçao do trabalhador de empresas industriais e da construção civil, como: declarações dos serviços onde atuam, carteira de trabalho, contracheque com documento de identidade ou crachá funcional.

Período da Campanha de vacinação

A campanha de vacinação tem previsão de ser iniciada em janeiro/2021. As etapas ocorrerão de acordo o Plano Paraense de Vacinação e a disponibilização de doses pelo Estado do Pará.

Estratégias de Vacinação

Com o intuito de evitar aglomerações e manter a organização nos estabelecimentos de saúde que irão disponibilizar as doses para a população serão adotadas algumas estratégias de vacinação da população prioritária conforme as fases da campanha:

- Definição de local de vacinação conforme número de pessoas por grupo priorizado.

Proposta:

ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO POR GRUPOS PRIORITÁRIOS (ATUALIZADA EM 31/03/2021)

FASES DA CAMPANHA	GRUPO PRIORIZADO	ESTRATÉGIA	LOCAL
1ª FASE	Trabalhadores de Saúde (40%).	CENTRALIZADA	SMSJ
	Pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência.	NÃO SE APLICA	
	Indígenas aldeados	CENTRALIZADA	ALDEIA JACUNDA
	Pessoas com Deficiência Institucionalizadas.	NÃO SE APLICA	
2ª FASE	Trabalhadores de Saúde (60%)	CENTRALIZADA	SMSJ
	Pessoas de 90 anos ou mais	IN LOCO	DOMICÍLIO
	Pessoas de 80 a 89 anos ou mais	CENTRALIZADA + SISTEMA DRIVE-THRU	DIA D - PRAÇA MUNICIPAL
	Pessoas de 75 a 79 anos	CENTRALIZADA + SISTEMA DRIVE-THRU	DIA D - PRAÇA MUNICIPAL
	Pessoas de 70 a 74 anos	CENTRALIZADA +SISTEMA DRIVE-THRU	DIA D - PRAÇA MUNICIPAL E PARÓQUIA SÃO JOAO BATISTA
	Pessoas de 65 a 69 anos	DESCENTRALIZADA + SISTEMA DRIVE-THRU	DIA D NA PRAÇA MUNICIPAL E DISPONÍVEL EM 5 UNIDADES DE SAUDE REFERENCIADAS
	Pessoas de 60 a 64 anos	DESCENTRALIZADA + SISTEMA DRIVE-THRU	DIA D NA PRAÇA MUNICIPAL E DISPONÍVEL EM 5 UNIDADES DE SAUDE REFERENCIADAS

	Povos e comunidades tradicionais quilombolas.	NÃO SE APLICA	
	Setores operacionais e grupos especiais da Segurança Pública	DESCENTRALIZADA	5 UNIDADES DE SAÚDE REFERENCIADAS
3ª FASE	**Pessoas com comorbidades - Pessoas com 18 a 59 anos com uma ou mais das comorbidades**		
	Diabetes melitus	Será definido um calendário de acordo com o mês de nascimento, distribuídos em 12 dias, sendo um dia para cada mês do ano, para que a população-alvo seja organizada ou se desloque até as unidades de saúde no dia da semana correspondente ao seu mês de nascimento.	12 DIAS D NA PRACA MUNICIPAL E 5 UNIDADES DE SAÚDE REFERENCIADAS
	Pneumopatias crônicas graves		
	Hipertensão Arterial Resistente (HAR)		
	Hipertensão arterial estágio 3		
	Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade		
	Insuficiência cardíaca (IC)		
	Cor-pulmonale e pulmonar		
	Cardiopatia hipertensiva		
	Síndromes coronarianas		
	Valvopatias		
	Miocardiopatias e Pericardiopatias		
	Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas		
	Arritmias cardíacas		
	Cardiopatias congênita no adulto		
	Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados		
	Doença cerebrovascular		
	Doença renal crônica		
	Imunossuprimidos		
	Anemia falciforme		
	Obesidade mórbida		
	Síndrome de down		
	Cirrose hepática		
4ª FASE	Profissionais da Segurança Pública na ativa.	CENTRAÇIZADA	NO QUARTEL
	Trabalhadores da Educação	Será definido um calendário de acordo com o mês de nascimento, distribuídos em 12 dias, sendo um dia para cada mês do ano, para que a população-alvo seja organizada ou se desloque até as unidades de saúde no dia da semana correspondente ao seu mês de nascimento.	12 DIAS D NA PRACA MUNICIPAL E 5 UNIDADES DE SAÚDE REFERENCIADAS
	Forças Armadas	DESCENTRALIZADA	5 UNIDADES DE SAÚDE REFERENCIADAS
	Pessoas em de rua	IN LOCO	IN LOCO
	Funcionários do sistema de privação de liberdade	IN LOCO	IN LOCO
	População privada de liberdade.	IN LOCO	IN LOCO
	Pessoas com deficiência permanente severa.	Será definido um calendário de acordo com o mês de nascimento, distribuídos em 12 dias, sendo um dia para cada mês do ano, para que a população-alvo seja organizada ou se desloque até as unidades de saúde no dia da semana correspondente ao seu mês de nascimento.	12 DIAS D NA PRACA MUNICIPAL E 5 UNIDADES DE SAÚDE REFERENCIADAS

5º FASE	Trabalhadores de Transporte Coletivo de Passageiros Urbano e de Longo Curso	DESCENTRALIZADA	5 UNIDADES DE SAÚDE REFERENCIADAS
	Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário	DESCENTRALIZADA	5 UNIDADES DE SAÚDE REFERENCIADAS
	Trabalhadores de Transporte aéreo	DESCENTRALIZADA	5 UNIDADES DE SAÚDE REFERENCIADAS
	Trabalhadores de Transporte Aquaviário	DESCENTRALIZADA	5 UNIDADES DE SAÚDE REFERENCIADAS
	Caminhoneiros	DESCENTRALIZADA	5 UNIDADES DE SAÚDE REFERENCIADAS
	Trabalhadores Portuários	DESCENTRALIZADA	5 UNIDADES DE SAÚDE REFERENCIADAS
	Trabalhadores Industriais	DESCENTRALIZADA	6 UNIDADES DE SAÚDE REFERENCIADAS

Para os grupos com maior número de pessoas, será feito um pré-cadastro através de aplicativo vinculado ao site da prefeitura municipal de Jacundá e será definido um calendário vacinal de acordo com o mês de nascimento, distribuídos em 12 dias, sendo um dia para cada mês do ano, para que a população-alvo seja organizada ou se desloque até as unidades de saúde no dia da semana correspondente ao seu mês de nascimento, exemplo:

DIAS DA SEMANA	MÊS DE NASCIMENTO
1 DIA	Janeiro
2 DIA	Fevereiro
3 DIA	Março
4 DIA	Abril
5 DIA	Maio
6 DIA	Junho
7 DIA	Julho
8 DIA	Agosto
9 DIA	Setembro
10 DIA	Outubro
11 DIA	Novembro
12 DIA	Dezembro

7.4 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A pandemia da COVID-19 apresentou uma necessidade tempestiva e efetiva de medidas de prevenção e controle sanitário, e diante disso, a Vigilância Sanitária, articulada com demais áreas e órgãos, também se constituiu como uma importante aliada. Ações regulatórias são imprescindíveis, realizadas por meio de Resoluções, assim como as fiscalizatória.

As práticas de enfrentamento consolidadas neste processo, compreendem a elaboração de Notas Orientativas, publicação de Resoluções, realização de diversas medidas educativas, investigações e inspeções necessárias ao contexto, e ainda, a instrumentalização para o registro dessas ações em sistemas de informação, de forma a diminuir risco de contágio do coronavírus.

Notas Orientativas

Dentre as estratégias adotadas para a elaboração de recomendações definidas pela Secretaria de Saúde, deve ser implantada a prática de publicação de Notas Orientativas. Tal prática teve como objetivo divulgar e tornar público, de forma rápida e efetiva, as informações discutidas e harmonizadas no âmbito técnico, e com uma identidade visual específica desenvolvida para caracterizar os materiais relacionados à Covid-19 no Município de Jacundá.

Após aprovadas, as Notas deverão ser enviadas para formatação na área técnica da VISA e encaminhadas para publicação no sítio eletrônico da Prefeitura de Jacundá pela equipe de Comunicação Social, ficando disponíveis para acesso e download.

As Notas Orientativas devem reunir assuntos com diferentes características, logo, a depender do tema, são construídas de forma conjunta, a fim de compilar a pluralidade de percepções e conhecimentos possíveis acerca de determinado assunto e assim tornarem-se efetivas para atender às necessidades das partes interessadas. As Notas tornaram-se instrumentos de trabalho e, portanto, passíveis de revisão a qualquer tempo quando identificada essa necessidade.

Ações educativas e de capacitação envolvendo diferentes públicos

Dentre os temas mais abordados nos processos orientativos estão as medidas de prevenção e controle da Covid-19, com ênfase no distanciamento, na higienização de mãos, limpeza e desinfecção de ambientes, medidas de precaução e uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Estas abordagens envolveram profissionais dos mais diferentes cenários, compreendendo desde sistemas prisionais, escolas, estabelecimentos comerciais, estabelecimentos públicos, a serviços de saúde.

8 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o novo coronavírus (2019-nCoV). As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda a assistência prestada.

8.1 ORGANIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE PARA CUIDADOS AO PACIENTE COM COVID-19

O cuidado à saúde da pessoa com COVID-19 nos serviços de saúde locais é de extrema importância, pois permitem às equipes de saúde lançarem mão dos insumos e recursos disponíveis nos serviços a fim de identificar os sinais de alerta e antecipar as medidas fundamentais para desfechos favoráveis desses casos.Conhecer e estabelecer fluxos para atendimento ao paciente suspeito ou confirmado de COVID-19 é extremamente importante, pois possibilita a realização de um atendimentoresolutivo, maior controle na disseminação da doença, além de garantir a continuidade da assistência nos diferentes níveis da Rede de Atenção à Saúde. As seguintesrecomendações podem auxiliar na organização dos serviços:

- Designar profissionais dedicados exclusivamente para o acolhimento e indicação do fluxo diferenciado para pacientes com sintomas respiratórios;
- Realizar classificação de risco na porta de entrada do serviço e encaminhamento subsequente para atendimento, objetivando diminuir o fluxo de pessoas em circulação, o tempo de contato entre pacientes e, consequentemente, a disseminação do vírus. Importante verificar viabilidade de fluxos distintos também para exames complementares, administração de medicamentos ou inalação;
- Os pacientes com sintomas respiratórios deverão usar máscara, conforme protocololocal. Encaminhá-los, em seguida, para área de espera exclusiva para esse fim. Ele deverá ser orientado a lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool 70% em gelpara que não contamine o espaço do atendimento com suas mãos;
- Orientá-los sobre não tocar na máscara, nos olhos, no nariz e na boca;

● Utilizar o EPI necessário para prestar assistência adequada, mas com segurança.Todo profissional em contato com pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 deverão atentar para uso correto dos EPI e adotar as medidas para evitar contaminação/contágio;
● Manter o ambiente de atendimento arejado e, caso haja ventiladores, ajustar o fluxo de ar na direção contrária ao profissional de saúde durante a assistência ao paciente e atentar para a limpeza frequente desses dispositivos. Paciente assintomático respiratório segue o fluxo normal do serviço no qual deu entrada (APS/ hospital) para investigação de outras patologias;
● Encaminhar o paciente sintomático respiratório com necessidade de internação hospitalar para área de observação exclusiva até sua estabilização ou quando necessária a transferência para serviço de referência. Ao paciente sintomático respiratório sem sinais de gravidade, orientar o tratamento domiciliar e realizar seu monitoramento;
● Evitar que materiais e medicamentos destinados à área dedicada para atendimento à COVID-19 sofram devolução. Se possível, montar uma farmácia satélite para atender rapidamente esta área.
● Sinalizar os ambientes, áreas e espaços destinados ao atendimento de pacientes com COVID-19;
● Viabilizar fluxo de limpeza da área exclusiva, separadamente das demais;
● Manter registro de todos os profissionais que prestarem assistência direta ou entrarem nos quartos ou áreas assistenciais de pacientes com diagnóstico ou suspeita de COVID-19.

Atendimento ambulatorial ou pronto atendimento

- Os pacientes e acompanhantes que chegarem para serem atendidos e tiverem sintomas de alguma infecção respiratória (por exemplo, tosse, coriza, febre, dificuldade para respirar) deverão seguir as ações preventivas como, por exemplo, fazer uso de máscara cirúrgica a partir da entrada do mesmo no serviço, se puder sertolerada.
- Para indivíduos que não puderem tolerar uma máscara cirúrgica caso esteja com secreção excessiva ou falta de ar, deve ser orientado que siga rigorosamente a higiene respiratória (cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com uso de papel descartável e realizar a higiene dasmãos).
- Se um caso suspeito ou confirmado chegar via transporte móvel de urgência os profissionais que realizaram o atendimento pré-hospitalar devem comunicar sobre os sintomas para a equipe do serviço de atendimento ambulatorial ou de pronto atendimento.

Centro de Atendimento COVID-19

O Centro de Atendimento, criado pelo Ministério da Saúde com unidade habilitada em Jacundá (junho /2020), busca conter a transmissibilidade do coronavírus ao reduzir a ida de pessoas com sintomas leves aos serviços de urgências ou hospitais, assim atuando na identificação precoce dos casos, com o adequado manejo das pessoas com síndrome gripal (SG) e Covid-19.

A Nota Técnica nº 18 contém diretrizes relacionadas à Portaria nº 1.445, de 29 de maio de 2020, que instituiu os Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 na APS. O principal objetivo desses estabelecimentos é o atendimento dos casos de SG leve, causada ou não pelo coronavírus. A proposta é que o serviço componha o fluxo de cuidado na Rede de Atenção à Saúde (RAS), atendendo os casos leves e encaminhando os casos graves para a rede de urgência e emergência ou rede hospitalar. Além de reduzir a circulação de pessoas com sintomas leves em outros serviços de saúde, a implantação dos Centros de Atendimento busca minimizar os impactos decorrentes da pandemia e permitir que os demais serviços da APS continuem atuando em suas atividades essenciais, como acompanhamento das pessoas com doenças crônicas, pré-natal, imunização, entre outras. É fundamental garantir a continuidade do cuidado às pessoas

que são acompanhadas periodicamente pelas equipes de Saúde da Família (eSF), equipes de Atenção Primária (eAP) e demais equipes e serviços da APS.

Implantado em local estratégico, territorialmente, sendo um anexo do hospital, com base em avaliação epidemiológica, de demanda e cobertura assistencial local. Nesse sentido, o Centro de Atendimento é a referência para o monitoramento de SG e Covid-19, fazendo comunicação com os outros serviços da atenção primária e vigilância para realizarem o monitoramento dos usuários sob sua responsabilidade.

Infraestrutura: Espaço físico mínimo, uma exigência do MS e ainda os gestores podem adaptar as salas já existentes no estabelecimento de saúde a fim de garantir a instalação adequada desses ambientes. Os consultórios mantidos limpos com frequência. Assegurando distanciamento mínimo entre o profissional e o usuário do serviço e garantimos a oferta de máscaras cirúrgicas para os usuários sintomáticos respiratórios logo na entrada dos estabelecimentos de saúde.

Ambientes	- 1 consultório - 1 sala de acolhimento - 1 sala de coleta Teste Rápido
Horário de funcionamento	40 horas semanais
Carga horária mínima por categoria profissional	Médico 40 horas
	Enfermeiro 40 horas
	Técnico de enfermagem 80 horas

Atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados

- Isolar precocemente pacientes suspeitos durante o transporte. O smesmos deverão utilizar máscara cirúrgica todo o momento, desde a identificação até chegada ao local deisolamento;
- Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante otransporte;
- Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) quando em contato com o caso suspeito, conforme apresentado na figura01;
- Realizar higiene das mãos com preparação alcoólicafrequentemente;
- Orientar pacientes e possíveis acompanhantes quanto à importância da higienização frequente das mãos;
- Comunicar imediatamente aos profissionais dos serviços de atendimento ambulatorial ou pronto atendimento se caso suspeito ouconfirmado;
- Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte. Após limpeza com água e sabão, a desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado para este fim, seguindo procedimento operacional padrão definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seusequipamentos;
- Reforçar a provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras N95,sabonete líquido, preparação alcoólica, lenços de papel, avental impermeável, óculos de proteção e luvas de procedimento) do veículo de transporte.

Observação: Deve-se evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados. Se a transferência do paciente for realmente necessária, este deve utilizar máscara cirúrgica, obrigatoriamente.

Os serviços de saúde que prestam atendimento ambulatorial ou de pronto atendimento aos casos suspeitos ou confirmados pelo novo coronavírus (2019-nCoV) devem, de acordo com sua

infraestrutura e processos internos:

- Estabelecer critérios de triagem para identificação e pronto atendimento doscasos.
- Orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a seremadotadas.
- Disponibilizar máscara cirúrgica para os pacientes e acompanhantes e prover condições para higiene das mãos.
- Manter casos suspeitos em área separada até atendimento ou encaminhamento ao serviço de referência (se necessário), limitando sua movimentação fora da área deisolamento.

A equipe do serviço de saúde deve orientar os pacientes a adotar as medidas de etiqueta respiratória:

- Orientar os pacientes a cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar (com cotovelo flexionado ou utilizando-se de um lenço descartável para higiene nasal), evitar o toque em mucosas de olho, nariz e boca e realizar higiene das mãosfrequentemente.
- Prover lenços descartáveis para higiene nasal na sala de espera e lixeira com acionamento por pedal para o descarte delenços.
- Prover dispensadores com preparações alcoólicas (sob as formas gel ou solução) para a higiene das mãos nas salas de espera e estimular a higiene das mãos após contato com secreçõesrespiratórias.
- Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contatomanual.
- Manter os ambientesventilados.
- Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas e telefones.
- Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes utilizados pelo paciente.
- Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha sido utilizado na assistência aopaciente.

Na chegada, triagem e espera de atendimento no serviço desaúde:

- O serviço de saúde deve adotar medidas para garantir que todos os casos suspeitos ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) ou outra infecção respiratória (por exemplo, febre e tosse) sigam os procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse e higiene das mãos durante todo o período que permanecerem naunidade.
- Disponibilizar alertas visuais (cartazes, placas e pôsteres) na entrada dos serviços de saúde e em locais estratégicos (áreas de espera, elevadores e lanchonetes) para fornecer aos pacientes e acompanhantes/ visitantes as instruções sobre higiene das mãos, higiene respiratória e etiqueta datosse;
- As instruções devem incluir o uso das máscaras cirúrgicas para cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar e a higiene dasmãos;
- Garantir que pacientes com sintomas suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) ou outra infecção respiratória (por exemplo, febre e tosse) não fiquem esperando atendimento entre outros pacientes;
- Definir um espaço separado e bem ventilado que permita que os pacientes em espera sejam separados e com fácil acesso a suprimentos de higiene respiratória e higiene dasmãos.

RECOMENDAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (2019-NCOV) EM SERVIÇOS DE SAÚDE (OMS, 28.01.2020).

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS E ACOMPANHANTES	• Usar máscaracirúrgica • Usar lenços de papel (tosse, espirros, secreçãonasal) • Higiene das mãos frequentes com água e sabonete líquido ou preparaçãoalcóolica
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	• Higiene das mãos frequentes com água e sabonete líquido ou preparaçãoalcóolica • Óculos de proteção ou protetorfacial • Máscara cirúrgica • Aventalimpermeável • Luvas deprocedimento Atenção: os profissionais de saúde deverão utilizar as máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como, por exemplo: intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coleta de amostras nasotraqueais e broncoscopias.
PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais de limpeza, nutrição, manutenção, etc.).	• Higiene dasmãos • Óculos de proteção ou protetorfacial • Aventalimpermeável • Luvas deprocedimento

Fonte: NT 04 ANVISA

OBSERVAÇÃO: Todas essas medidas são baseadas no conhecimento atual sobre os casos de infecção pelo novo coronavírus e podem ser alteradas conforme novas informações disponibilizadas pelos órgãos legais vigentes do país.

8.2 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES

Uma das formas de contágio do coronavírus é o contato com superfícies e objetos contaminados e também com pessoas doentes, através do toque de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse. A ANVISA publicou em outubro de 2020, o manual Limpeza e Desinfecção de Superícies (ANEXO 03) onde orienta sobre a limpeza e desinfecção correta dos ambientes, utensílios e objetos.

Sabe-se que a sobrevida do vírus varia de acordo com o tipo de superfície: aço inoxidável - 3 dias; plástico - 3 dias; papelão - 1 dia; cobre - 4 horas. Devido a isso, a desinfecção e limpeza devem abranger todos os possíveis locais que podem estar com o coronavírus presente, incluindo o chão, maçanetas, corrimão, interruptores de luz, superfícies de móveis, chaves, embalagens de produtos etc.

a) AMBIENTE DOMICILIAR E COMERCIAL

As medidas de limpeza e desinfecção são fundamentais para contribuir na prevenção da transmissão da COVID-19 e para isso algumas orientações são fundamentais:

• Aumentar a frequência de limpeza dos ambientes;

• Desinfetar com álcool a 70%, ou produto de ação similar, os locais habitualmente mais tocados: maçanetas, interruptores, janelas, telefone, teclado do computador, controle remoto, elevadores, itens de uso pessoal (canetas, aparelhos de celular, chaves, óculos), entre outros;

• Manter os ambientes arejados e ventilados a maior parte do tempo evitando, sempre que possível, o uso de ar condicionado;

• Quando utilizado sistema de ar condicionado, este deve ser mantido com seus componentes limpos e com a manutenção preventiva em dia, sob responsabilidade de um profissional habilitado, adotando estratégias que garantam maior renovação do ar e maior frequência na limpeza dos componentes.

• Em espaços comerciais os trabalhadores responsáveis pela limpeza e desinfecção de ambientes devem ter acesso a Equipamentos de Proteção Individual, como: luvas de borracha de cano longo, gorros ou toucas, óculos de acrílico, máscaras, aventais (impermeáveis quando risco de produzir umidade durante a execução da atividade), sapatos ou botas antiderrapantes. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
• Recomenda-se a forma de varredura úmida dos ambientes, com mops ou rodos e panos de limpeza. Este método evita a dispersão de microrganismos veiculados por meio das partículas de poeira;
• Os panos devem ser exclusivos para uso em cada ambiente. Portanto, panos usados na limpeza de banheiros não devem ser usados na limpeza de outros locais da casa, por exemplo. Ainda, devem estar sempre limpos e alvejados.

b) AMBIENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

As medidas de limpeza e desinfecção são fundamentais para contribuir na prevenção da transmissão da COVID-19 e para isso algumas orientações são fundamentais:

• Todo Estabelecimento de Assistência a Saúde (EAS) deve estabelecer de forma clara quais os possíveis riscos aos quais os trabalhadores estão expostos, dentre eles o risco biológico (representado pela probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, como o vírus SARS-CoV2). A partir desta definição, os ambientes considerados críticos devem ser limpos e desinfetados com maior frequência;

• Todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados devem elaborar e implementar um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

• Os trabalhadores da limpeza devem fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a finalidade a que se destinam, responsabilizando-se pela limpeza, guarda e conservação, substituindo-os quando houver qualquer alteração que os tornem impróprios para uso.

• Os EPI devem ser utilizados pelos trabalhadores durante a execução de atividades que possam provocar contaminação da roupa com sangue e fluídos corpóreos ou por patógenos. Sendo que o estabelecimento é responsável pelo fornecimento de EPI apropriados e em quantidade suficiente aos trabalhadores do Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies. Nos locais de assistência ao paciente suspeito ou confirmado de contaminação por COVID-19 estes trabalhadores devem utilizar: avental (impermeável, para uso sobre o uniforme e em situações envolvendo atividades com risco de respingos); luvas de borracha resistentes aos produtos, preferencialmente de punho longo; óculos de proteção; máscara cirúrgica (em áreas de isolamento para aerossóis são indicadas as máscaras de proteção respiratória do tipo N95 ou PFF2); calçados fechados (inclusive no calcanhar e dorso dos pés) impermeáveis e com sola antiderrapante impermeáveis e com sola antiderrapante; gorro (deve ser usado em área especiais nas quais são exigidas a paramentação completa por parte dos profissionais da instituição. Para as demais áreas do EAS, recomenda-se que os trabalhadores do Serviço de Limpeza e Desinfecção mantenham os cabelos presos e arrumados, sendo que para os trabalhadores do sexo masculino são imprescindíveis cabelos curtos e barba feita).

• O trabalhador do Serviço de Limpeza e Desinfecção deve apresentar-se com uniforme completo, manter cabelos penteados e presos ou curtos; unhas curtas, limpas, sem esmalte ou unhas postiças. Também não deve fazer uso de adornos, como: relógios, pulseiras, anéis, brincos,

colares, piercing e outros.

• Deve haver kit de limpeza e desinfecção de superfície exclusivo para ambientes destinados ao isolamento de pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-19. Nestes locais utilizar, preferencialmente, panos de limpeza descartáveis;

• Adotar a técnica da varredura úmida, que permite a remoção de poeira e possíveis detritos soltos no chão por meio do uso de pano úmido e rodo. Esses resíduos não podem ser levados até a porta de entrada, devendo ser recolhidos do ambiente com o auxílio de pá. Deve-se iniciar a limpeza pelos cantos.

• Sempre que houver presença de matéria orgânica em superfícies, essa deverá ser removida. A seguir, realizar a limpeza e, posteriormente, a desinfecção. É imprescindível que o local seja rigorosamente limpo antes da desinfecção.

• Não abrir ou fechar portas com mãos enluvadas;

• As luvas de borracha devem ser lavadas antes de serem descalçadas e sempre ao término da limpeza.

• Antes e após a retirada das luvas o trabalhador do Serviço de Limpeza e Desinfecção deve higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel 70%;

• Após o uso, todos os equipamentos devem ser limpos a cada término da jornada de trabalho;

• Utilizar somente produtos saneantes padronizados para uso em Serviços de Saúde, na concentração e tempo recomendados pelo fabricante e pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar;

• A mistura de produtos saneantes não previamente autorizados é proibida, bem como o reaproveitamento de embalagens vazias com produtos saneantes diferentes do rótulo original. Também é necessário atenção para utilização de produtos que estejam dentro do período de validade.

• A limpeza dos ambientes destinados ao isolamento de pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-19 deve ser feita diariamente, a cada troca de plantão, e sempre quando necessário, antecedendo a limpeza concorrente de pisos. Merece maior atenção, a limpeza das superfícies horizontais que tenham maior contato com as mãos dos pacientes e das equipes, tais como maçanetas das portas, telefones, interruptores de luz, grades da cama, chamada de enfermagem e outras;

Para que a desinfecção atinja seus objetivos, torna-se imprescindível a utilização das técnicas de limpeza e posteriormente, utilização de desinfetante especificado pelo SCIH. A responsabilidade na seleção, escolha e aquisição dos produtos saneantes deve ser do SCIH, conjuntamente com o Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde ou Hotelaria Hospitalar, assim como do representante do Setor de Compras da instituição.

Quadro abaixo apresenta produtos de limpeza e desinfecção de superfícies em Serviços de Saúde

PRODUTOS DE LIMPEZA/ DESINFECÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MODO DE USAR
Água	Limpeza para remoção de sujidade	Técnica de varredura úmida ou retirada de pó
Água e sabão ou detergente		Friccionar o sabão ou detergente sobre a superfície
Água		Enxaguar e secar
Álcool a 70%	Desinfecção de equipamentos e superfícies	Fricções sobre a superfície a ser desinfetada
Compostos fenólicos	Desinfecção de equipamentos e superfície	Após a limpeza, imersão ou fricção. Enxaguar e secar
Quaternário de amônia	Desinfecção de equipamentos e superfícies	Após a limpeza, imersão ou fricção. Enxaguar e secar
Compostos liberadores de cloro ativo	Desinfecção de superfícies não-metálicas e superfícies com matéria orgânica	Após a limpeza, imersão ou fricção. Enxaguar e secar
Oxidantes Ácido peracético (associado ou não a peróxido de hidrogênio)	Desinfecção de superfícies	Após a limpeza, imersão ou fricção. Enxaguar e secar

Anexo, nota técnica emitida pela Vigilância em Saúde de Jacundá onde orienta sobre a desinfecção de ambietes.

8.3 PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

a) Não há uma orientação especial quanto ao processamento de equipamentos, produtos para saúde ou artigos utilizados na assistência a casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus(2019-nCoV).

b. O processamento deve ser realizado de acordo com as características, finalidade de uso e orientação dos fabricantes e dos métodos escolhidos. Além disso, devem ser seguidas as determinações previstas na RDC nº 15, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html

c. Equipamentos, produtos para saúde ou artigos para saúde utilizados em qualquer paciente devem ser recolhidos e transportados de forma a prevenir a possibilidade de contaminação de pele, mucosas e roupas ou a transferência de microrganismos para outros pacientes ou ambientes. Por isso é importante frisar a necessidade da adoção das medidas de precaução na manipulação destesmateriais.

d. O serviço de saúde deve estabelecer fluxos, rotinas de retirada e de todas as etapas do processamento dos equipamentos, produtos para saúde ou artigos utilizados durante aassistência.

8.4 PROCESSAMENTO DE ROUPAS

Não é preciso adotar um ciclo de lavagem especial para as roupas provenientes de casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus (2019-nCoV), podendo ser seguido o mesmo processo estabelecido para as roupas provenientes de outros pacientes emgeral.

Porém, ressaltam-se as seguintesorientações:

Na retirada da roupa suja deve haver o mínimo de agitação e manuseio, observando-se as medidas de precauções já descritas anteriormente nestedocumento.

Roupas provenientes dos isolamentos não devem ser transportadas por meio de tubos dequeda.

Nota: Outras orientações sobre o tema podem ser acessadas no Manual de Processamento de

Roupas de Serviços de Saúde: prevenção e controle de riscos da ANVISA, disponível no link: http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/processamento_roupas.pdf

8.5 TRATAMENTO DE RESÍDUOS

De acordo com o que se sabe até o momento, o novo coronavírus (2019-nCoV) pode ser enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de Risco dos Agentes Biológicos, publicada em 2017, pelo Ministério da Saúde http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/classificacao_risco_agentes_biologicos_3ed.pdf, sendo sua transmissão de alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Portanto, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) **devem ser enquadrados na categoria A1**, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222, de 28 de março de 2018 (disponível em ttp://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626- 8448-c9aa426ec410).

Os resíduos devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 48 horas e identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantosarredondados.

Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmenteadequada.
Ressalta-se ainda, que conforme a RDC/Anvisa nº 222/18, os serviços de saúde devem elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, que é o documento que aponta e descrevem todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, observadas suas características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem como as ações de proteção à saúde pública, do trabalhador e do meioambiente.

9 CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde deverá promover treinamentos relacionados à manejos clínicos, fluxos de atendimento, segurança do paciente, medidas de prevenção e contole.
O serviço de saúde deve certificar-se de que os profissionais de saúde estão instruídos, treinados antes de cuidar de um caso suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus. Deverá ter documentado os treinamentos realizados com os profissionais das unidades de Saúde.

10 PLANO DE AÇÃO de ACORDO RISCO DO CORONAVÍRUS E O IMPACTO NA SAÚDE PÚBLICA

Três níveis de ativação compõe este plano de contingência: **Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública.** Cada nível é baseado na avaliação do risco do Coronavírus e o impacto na saúde pública. Questões importantes são consideradas nessa avaliação:

a) Transmissibilidade da doença: Como seu modo de transmissão;
b) Propagação geográfica do COVID-19 entre humanos e animais;

c) Gravidade clínica da doença: Complicações graves, internações e mortes;
d) Vulnerabilidade da população: Incluindo imunidade pré-existente, grupos-alvo com maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;
e) Disponibilidade de medidas preventivas e possíveis tratamentos.

A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/jacundá) destaca que, até o momento, fatos e conhecimentos sobre o COVID-19 disponíveis são limitados. As evidências epidemiológicas e clínicas ainda estão sendo descritas e a história natural desta doença está sendo construída.O risco será avaliado e revisto periodicamente pelo Ministério da Saúde, tendo em vista o desenvolvimento de conhecimento científico e situação em evolução, para garantir que o nível de resposta seja ativado e as medidas correspondentes sejam adotadas.

O Alerta: Corresponde a uma situação em que o risco de introdução do COVID-19 no Brasil seja elevado e não apresente casos suspeitos.

O Perigo Iminente: Corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito.

O Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN): Situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19), no território nacional, ou reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Estas situações configuram condições para recomendação ao Ministro da Saúde de declaração de ESPIN, conforme previsto no Decreto nº 7.616 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN. Destaca-se aqui, a publicação da Portaria nº 188, de 03 de Fevereiro de 2020 a qual: “Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) de decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”.

10.1 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS SEGUNDO NÍVEL DE ATIVAÇÃO

NÍVEL 1: ALERTA

Componente: *Vigilância em Saúde*

- Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde.
- Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências ou recomendações da OMS.
- Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para infecção humana por COVID-19.
- Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo COVID-19, conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação orientado pelo MS.
- Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde.
- Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica global, com orientações para a preparação de resposta, com medidas de prevenção e controle para a infecção humana por COVID-19.

- Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.
- Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta respiratória e higiene das mãos.
- Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto à prevenção e controle a infecção humana por COVID-19.
- Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos suspeitos a bordo dos meios de transporte ou nos pontos de entrada conforme protocolo da ANVISA.

Componente: *Suporte laboratorial*

- Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a infecção humana por COVID-19 junto à rede laboratorial para os vírus respiratórios.
- Estabelecer protocolos de diagnóstico para a infecção humana por COVID-19, de acordo com as recomendações da OMS.
- Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana por COVID-19 e outros vírus respiratórios para a rede laboratorial.
- Seguir fluxos de laboratórios de referência para envio de amostras para infecção humana por COVID-19 e outros vírus respiratórios.
- Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana por COVID-19 e outros vírus respiratórios.
- Seguir o fluxo de transporte das amostras do Lacen ao laboratório de referência.
- Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais da rede pública, para os casos suspeitos de infecção humana por COVID-19.

Componente: *Rede Assistencial*

- Orientar a atenção primária, atenção pré-hospitalar e atenção hospitalar sobre manejo clínico e classificação de risco diante de um caso suspeito de infecção humana por COVID-19.
- Desenvolver capacitações para os profissionais de saúde da quanto ao acolhimento, cuidado, medidas de isolamento, limpeza e desinfecção de superfícies, higienização das mãos na atenção primária assistência pré-hospitalar e hospitalar.
- Orientar o monitoramento de casos de SG e SRAG nos serviços de saúde.
- Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos para a infecção humana por COVID-19.
- Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana por COVID-19.
- Desenvolver fluxogramas/protocolos de acolhimento, triagem e espera por atendimento para usuários com sintomas respiratórios.
- Quantificar estoques de insumos padrão, incluindo medicamentos e EPIs.

Componente: *Assistência farmacêutica*

- Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana por COVID-19.
- Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes.

- Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço farmacêutico.
- Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir.
- Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal.
- Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a demanda.

Componente:*Comunicação de risco*

- Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e informações pertinentes de prevenção e controle para infecção humana por COVID-19.
- Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de serviços de saúde e população.
- Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta respiratória e higienização das mãos para a prevenção da COVID-19.
- Definir, em conjunto com os gestores, o porta-voz que será responsável pela interlocução com os veículos de comunicação.
- Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de prevenção e controle da COVID-19.
- Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas.

Componente: *Gestão*

- Articular com gestores o acompanhamento da execução do Plano de Contingência de Infecção por COVID-19.
- Divulgar material desenvolvido pelas áreas técnicas (protocolos, manuais, guias, notas técnicas e informativas).
- Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário epidemiológico e o risco de introdução da COVID-19.
- Articular junto a outros órgãos o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de alerta.
- Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para a COVID-19.
- Monitorar os estoques dos insumos existentes (medicamentos e insumos laboratoriais).
- Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais, guias, notas técnicas).

NÍVEL 2: PERIGO IMINENTE

Componente: *Vigilância em Saúde*

- Acompanhar e monitorar os rumores sobre casos suspeitos.
- Acompanhar a situação epidemiológica e divulgar Boletins Epidemiológicos produzidos pela SVS/MS.

- Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências ou recomendações da OMS.
- Intensificar orientações sobre notificação e investigação de casos potencialmente suspeitos de infecção por COVID-19.
- Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção pelo COVID-19.
- Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a situação epidemiológica da Infecção Humana por COVID-19 para a rede de atenção à saúde.
- Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz monitoramento de informações e investigação intersetorial e resposta frente a casos suspeitos de infecção humana por COVID-19.
- Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica global e nacional, com orientações para medidas de prevenção e controle para infecção humana pelo Coronavírus.
- Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.
- Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde.

Componente: *Suporte Laboratorial*

- Fortalecer os fluxos estabelecidos para o diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a infecção humana por COVID-19, junto à rede laboratorial de referência para os vírus respiratórios.
- Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana por COVID-19 de acordo com as recomendações da OMS.
- Realizar levantamento de capacidade de resposta para o diagnóstico de infecção humana pelo Coronavírus no Lacen.
- Garantir os insumos para diagnóstico da influenza e outros vírus respiratórios para a rede laboratorial.
- Monitorar os fluxos de transporte para o envio de amostras para os laboratórios de referência.
- Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para COVID-19 e outras doenças respiratórias.
- Comunicar a vigilância epidemiológica os resultados laboratoriais para adoção de medidas de prevenção e controle.
- Apoiar os laboratórios de referência na realização de diagnóstico de RT-PCR em tempo real para a COVID-19 de acordo com os procedimentos e recomendações da OMS.
- Estabelecer o fluxo para apoiar e garantir o transporte das amostras do Lacen ao laboratório de referência.
- Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais da rede pública, para os casos suspeitos de COVID-19 sobre a importância da coleta, envio do diagnóstico para os laboratórios públicos ou de referência.
-

Componente: *Rede Assistencial*

- Implantar e acompanhar o seguimento dos fluxogramas/protocolos de acolhimento para usuários com sintomas respiratórios para a Rede de Atenção à Saúde.
- Mobilizar os responsáveis pelos serviços de saúde públicos e privados a executarem seus protocolos, fluxos e rotinas para o acolhimento, notificação, atendimento, medidas de prevenção e controle, entre outros.

- Estabelecer junto às unidades de saúde a importância de implementar precauções para gotículas/aerossóis de acordo com cada caso e gravidade no enfrentamento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.
- Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de internação com isolamento;
- Apoiar na elaboração de fluxos intra-hospitalares para o itinerário do paciente e desenvolvimento das atividades pelos profissionais na avaliação e monitoramento dos casos suspeitos ou confirmados.
- Estimular a capacitação em serviço (serviços públicos e privados) para atualização do cenário global e nacional da COVID-19.
- Estabelecer e apoiar o uso de Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais do SUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para COVID-19, conforme recomendação da ANVISA.

Componente: *Assistência Farmacêutica*

- Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes.
- Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço farmacêutico.
- Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir.
- Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a demanda.

Componente: *Vigilância Sanitária*

- Divulgar material informativo para orientar os viajantes quanto a prevenção e controle da doença COVID-19.
- Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos suspeitos a bordo dos meios de transporte ou nos pontos de entrada.

.

- Mobilizar e capacitar a rede de vigilância em saúde, considerando os planos de contingência locais, da necessidade da preparação e adoção de medidas para o enfrentamento da COVID-19.
- Definição e divulgação dos equipamentos de proteção individual necessários aos atendimentos de casos suspeitos ou confirmados sobre as medidas de precaução e controle.

Componente: *Comunicação de Risco*

- Definir estratégias de publicidade e informação à população e à imprensa para a prevenção da COVID -19.
- Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de serviços de saúde e população sobre a infecção humana por COVID-19.
- Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle da COVID-19 . Emitir orientações de saúde sobre a COVID-19, para instituições privadas, escolas e público em geral,

com o apoio dos órgãos parceiros.

- Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta respiratória e higienização das mãos para a prevenção da COVID-19.
- Elaboração e divulgação de campanhas e materiais informativos sobre as medidas de prevenção e controle da COVID-19.
- Divulgação de informações sobre a COVID-19 nas redes sociais.

Componente: *Gestão*

- Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, ANVISA, e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle da COVID-19.
- Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário epidemiológico da COVID-19.
- Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de alerta.
- Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para a COVID-19.
- Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle da COVID-19.
- Monitorar os estoques dos insumos existentes a nível municipal (medicamentos e insumos laboratoriais).
- Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais, guias, notas técnicas).

NÍVEL 3: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE INTERESSE NACIONAL

Componente:*Vigilância em Saúde*

- Intensificar orientações sobre notificação e investigação de casos potencialmente suspeitos de COVID-19.
- Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de COVID-19.
- Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a situação epidemiológica da COVID-19 para a rede de atenção à saúde.
- Intensificar monitoramento de boas práticas laboratoriais nos procedimentos de coleta, armazenamento e transporte de amostras biológicas de casos suspeitos de COVID-19.
- Prestar apoio técnico as ações de Vigilância Epidemiológica sempre que necessário.
- Divulgar as normas e diretrizes do MS para a prevenção e controle da COVID-19.
- Realizar investigação do caso confirmado pela COVID-19.
- Manter a Rede de vigilância e atenção à saúde organizada sobre a situação epidemiológica do país e a necessidade de adoção de novas medidas de prevenção e controle da COVID-19.
- Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde.
- Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos confirmados de COVID-19.
- Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos e confirmados de COVID-19.

Componente: *Suporte Laboratorial*

- Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para detecção de COVID-19, junto à rede laboratorial de referência para os vírus respiratórios.
- Aplicar os protocolos de diagnóstico para COVID-19, de acordo com as recomendações da OMS.
- Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o Sars- CoV- 2 e outros vírus respiratórios.
- Apoiar e garantir o transporte das amostras ao laboratório de referência . Lacen
- Apoiar os serviços privados sobre a importância da coleta, fluxo de envio e diagnóstico de COVID-19, de acordo com os protocolos.

Componente: *Rede Assistencial*

- Apoiar o funcionamento adequado e oportuno da organização da rede de atenção para atendimento ao aumento de contingente de casos de SG, SRAG e de COVID-19.
- Apoiar a ampliação de leitos, reativação de áreas assistenciais obsoletas, ou contratação de leitos com isolamento para o atendimento dos casos de SG, SRAG e de COVID-19.
- Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais atuantes no atendimento aos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, nos serviços públicos e privados, conforme recomendações da ANVISA.

Componente: *Assistência Farmacêutica*

- Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes.
- Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço farmacêutico.
- Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir.
- Monitorar o estoque de medicamentos.
- Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a demanda.

Componente: *Vigilância Sanitária*

- Intensificar a divulgação do material informativo para orientar os viajantes quanto à prevenção e controle da COVID-19.
- Reforçar as orientações sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual necessários aos atendimentos de casos suspeitos e demais medidas de precaução.
- Estabelecer medidas adicionais estabelecidas pela OMS como avaliação prévia de sintomáticos ou assintomáticos para desembarque ou declaração do viajante considerando o histórico de viagem e autodeclaração de saúde.
- Mobilizar e orientar a comunidade rodoviária para adoção de medidas para o enfrentamento da COVID-19.

Componente:*Comunicação de Risco*

- Emitir orientações de saúde para instituições privadas, escolas e público em geral.
- Elaborar junto com a área técnica materiais informativos/educativos sobre a COVID-19 e distribuí-los para a população, profissionais de saúde, jornalistas e formadores de opinião.
- Monitorar as redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas.
- Disponibilizar material informativo/educativo para públicos específicos: gestores, profissionais de saúde, viajantes, escolas, dentre outros.
- Promover coletivas de imprensa com o porta-voz responsável pela interlocução com os veículos de comunicação.

Componente:*Gestão*

- Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, Anvisa, e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do vírus SARS-CoV-2.
- Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário epidemiológico da COVID-19.
- Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de alerta.
- Garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico da COVID-19.
- Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para o vírus SARS-CoV-2.
- Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais, guias, notas técnicas).
- Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus SARS-CoV-2.

18. AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Componente: *Gestão*

- Elaboração do Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento à Doença COVID-19
- Publicação de Decretos e Resoluções que estabelecem apoio às ações de combate a doença COVID-19:
- Realização diária das reuniões com Equipe de gestão emergencial COVID-19;
- Divulgação de boletim informativo de atualização diária;
- Fornecimento de suporte e estímulo para a realizaçãodas ações integradas;
- Remanejamento dos servidores lotados na assistência, portadores de imunodeficiências, doenças cardíacas e/ou pulmonares,gestantes e idosos;
- Aquisição de testes rápidos para detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti COVID-19 para ser utilizado na população
- Implantação de centro de apoio psicológico para pacientes e profissionais da saúde;
- Implantação do hospital de campanha para tratamento hospitalar de pacientes com diagnóstico de coronvirus;
- Implantação do centro de Atendimento covid-19
- Contratação de profissionais: médico, enfermeiro e fisioterapeuta para atuarem no centro de atendimento e hospital de campanha.;

- Ações da Superintendência de Economia em Saúde (SUPES)
- Realização de compra de itens: Conforme a necessidade de cada setor com o aumento da demanda de materiais específicos, tais como medicamentos, materiais médico-hospitalares, tanto como de consumo quanto permanentes, foram realizadas compras emergenciais e há processos que encontram-se em andamento.

Componente: *Vigilância em Saúde*

- Divulgação e orientações de Notas Técnicas;
- Elaboração do fluxo de atendimento no município de Jaundá em casos suspeitos e confirmados de COVID-19;
- Elaboração de boletim informativo de atualização diária;
- Capacitação dos profissionais de saúde;
- Elaboração de material informativo para a população;
- Orientação para estabelecimentos comerciais e outros, supermercados, igrejas, academias, escolas;
- Distribuição de máscaras não profissional a população;
- Execução da Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza;
- Instituição de barreira sanitária;

Componente: *Suporte Laboratorial*

- Organização do fluxo para análise de amostras de casos suspeitos de infecção pelo COVID-19 pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN);

Componente:*Rede Assistencial*

- Elaboração de Fluxogramas e Orientações;
- Orientações sobre equipamentos de proteção individual (EPI);
- Plano de reorganização das equipes de NASF para apoio às unidades;
- Teleatendimento e telemonitoramento;
- Apoio na implantação de fluxos, notas técnicas e monitoramento às unidades de saúde da atenção primária;
- Serviço de teleatendimento para apoio psicológico aos servidores
- Implantação do Fluxo Fast Track nas unidades assistenciais;

Componente: *Assistência Farmacêutica*

- Monitoramento contínuo dos estoque;
- Orientações sobre fluxos:
- Solicitação de medicamentos:
- Estabelecimento de logística de controle, distribuição e remanejamento de medicamentos;

Componente: *Vigilância Sanitária*

- OrientaçõesNotas Técnicas:
- Orientações da Vigilância Sanitária para o Terminal Rodoviário, de 18 de março de 2020;
- Nota Técnica nº 01/2020/SEFIS/CVS/SVS/SESAU, de 23/03/2020- Orientações para o manuseio de cadáveres suspeitos ou confirmados para covid-19 e orientação para diretores de funerais e outros trabalhadores funerários;
- Terminais Rodoviários;
- Serviços de Saúde:
- Higienização diária as unidades de saúde com produto quimico de sensibilidade comprovada;
- Atendimento de Denúncias;

Componente: *Comunicação de Risco*

- Divulgação de informações atualizadas através de mídias e rede sociais;
- Realização de campanha digital:
- Compartilhamento de informações diariamente:
- Rastreamento e esclarecimento sobre postagens com conteúdo falsos ou errôneos;
- Realização de coletivas de imprensa;
- Atendimento e divulgação de informações à imprensa externa

4. REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo de Tratamento Novo Coronavírus. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Atenção Hospitalar, Urgência e Domiciliar. Brasília, 2020. Disponível em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/05/Protocolo-de-manejo-clinico-para-o-novo-coronavirus-2019-ncov.pdf

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde. Classifcação de risco dos agentes biológicos - 3. Ed.; 2017 – Fev. 2020. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/classificacao_risco_agentes_biologicos_3ed.pdf

Brasil. Ministério da saúde. Nota Técnica nº 04/2020 IMS/GGTES/ANVISA. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-Ncov) – Fev. 2020. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES- ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28

Brasil. Governo do Estado de Minas Gerais. Secretaria de Estado da Saúde. **Protocolo coronavírus 2019-Ncov** - Fev. 2020. Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/PROTOCOLO_CORONAVIRUS_FINAL.pdf

Brasil. Boletim Epidemiológico 04. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde - Fev. 2020. Disponível em: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/23/Boletim_epidemiologico_SVS_04.pdf

Centers for Disease Control and Prevention. Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Known or Patients Under Investigation for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) in a Healthcare Setting, 2020. Disponível em:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html

Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico Nº 01 Secretaria de Vigilância em Saúde SVS/MS-COE - Jan. 2020. Disponível em: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/28/Boletim-epidemiologico-SVS-28jan20.pdf

World Health Organization. WHO. Novel Coronavirus (2019-nCoV) technical guidance, 2020. Disponível em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

World Health Organization. WHO. Advice on the use of masks the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak Interim guidance 29 January 2020 WHO/nCov/IPC_Masks/2020.1. Disponível: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

ANVISA.ORIENTAÇÕES GERAIS – Máscaras faciais de uso não profissional. Brasília, 03 de abril de 2020

ANEXO 01

CORONAVÍRUS COVID-19

FLUXO DE MANEJO CLÍNICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

Versão 9

PACIENTE COM QUALQUER SINTOMA DE SÍDROME GRIPAL

- Febre >= 37,8°C (aferida ou referida)
- Tosse
- Dor de garganta
- Dificuldade respiratória

DISQUE SAÚDE 136

UBS COM PORTA DE ENTRADA RESOLUTIVA, DE IDENTIFICAÇÃO PRECOCE E ENCAMINHAMENTO CORRETO DE CASOS GRAVES

Paciente com prioridade no atendimento:
Pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos (HIV+, transplantados, etc), pacientes com doenças crônicas, gestantes e puérperas

CONTROLE PRECOCE

- Forneça máscara cirúrgica para a pessoa e a oriente quanto à forma correta de colocá-la. Forneça meios para a pessoa higienizar as mãos (álcool gel ou água e sabão);
- A pessoa deve ser conduzida para uma área separada ou para uma sala específica visando ao isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado.

ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE E MANEJO CLÍNICO

APS/ESF
Síndrome Gripal confirmada:
Febre
e
Tosse OU dor de garganta OU dificuldade respiratória
e
Ausência de condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de referência/ atenção especializada

CENTRO DE REFERÊNCIA/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Síndrome gripal com ou os seguintes sinais ou sintomas de gravidade

- Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente
- Sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência respiratória avaliada de acordo com a idade
- Piora nas condições clínicas de doenças de base
- Hipotensão

Em crianças: além dos anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

OU

Condições clínicas de risco

- Diabetes (conforme juízo clínico)
- Doenças cardíacas crônicas descompensadas
- Doenças respiratórias crônicas descompensadas
- Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)
- Imunossuprimidos
- Portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica
- Gestante de alto risco
- Doença hepática em estágio avançado
- Obesidade (IMC >=40)

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

Via formulário pelo e_SUS VE
https://notifica.saude.gov.br/

SÍNDROME GRIPAL LEVE

MANEJO CLÍNICO NA APS

MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

- Prescrição de fármacos para o controle de sintomas, caso não haja nenhuma contraindicação
- Prescrever oseltamivir se Síndrome Gripal e pessoa com condições de risco

MEDIDAS CLÍNICAS

- O acompanhamento do paciente deve ser feito, preferencialmente por telefone, a cada 24hs em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a cada 48hs nos demais, até completar 14 dias do início dos sintomas.
- Caso seja necessário, realizar atendimento presencial, idealmente no domicílio.
- Manter alimentação balanceada e uma boa oferta de líquidos.

Verificar situação vacinal para gripe (se grupo de risco – gestante, crianças, puérperas e idosos) e vacinar se necessário.

Reavaliação/ Acompanhamento clínico

Apresenta sinais/ sintomas de gravidade?

NÃO

SIM

Equipe da APS/ESF fica responsável pelo encaminhamento do paciente para o centro de referência/ atenção especializada

Atestado médico até o fim do período de isolamento

Monitoramento por telefone, a cada 24h em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a cada 48h nos demais, até completar completar 14 dias do início dos sintomas. Caso seja necessário, realizar atendimento presencial, idealmente no domicílio.

DESFECHO

CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO

Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes.

Manter paciente em quarto isolado e bem ventilado até o fim do período sintomático. Destacam-se os seguintes fatores do cuidado do paciente em isolamento: a higiene respiratória e os hábitos saudáveis de alimentação. Todos os contatos domiciliares do paciente também deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias. Caso apresentar os sintomas, deverão entrar em contato com a equipe de saúde para receber atendimento.

Para mais informações sobre orientaçãoes quanto ao isolamento domiciliar do paciente e precauções gerais e do cuidador, ver Protocolo de Manejo Clínico.

SÍNDROME GRIPAL GRAVE

Transporte apropriado

Centro de referência/ atenção especializada

Atestado médico até o fim do isolamento

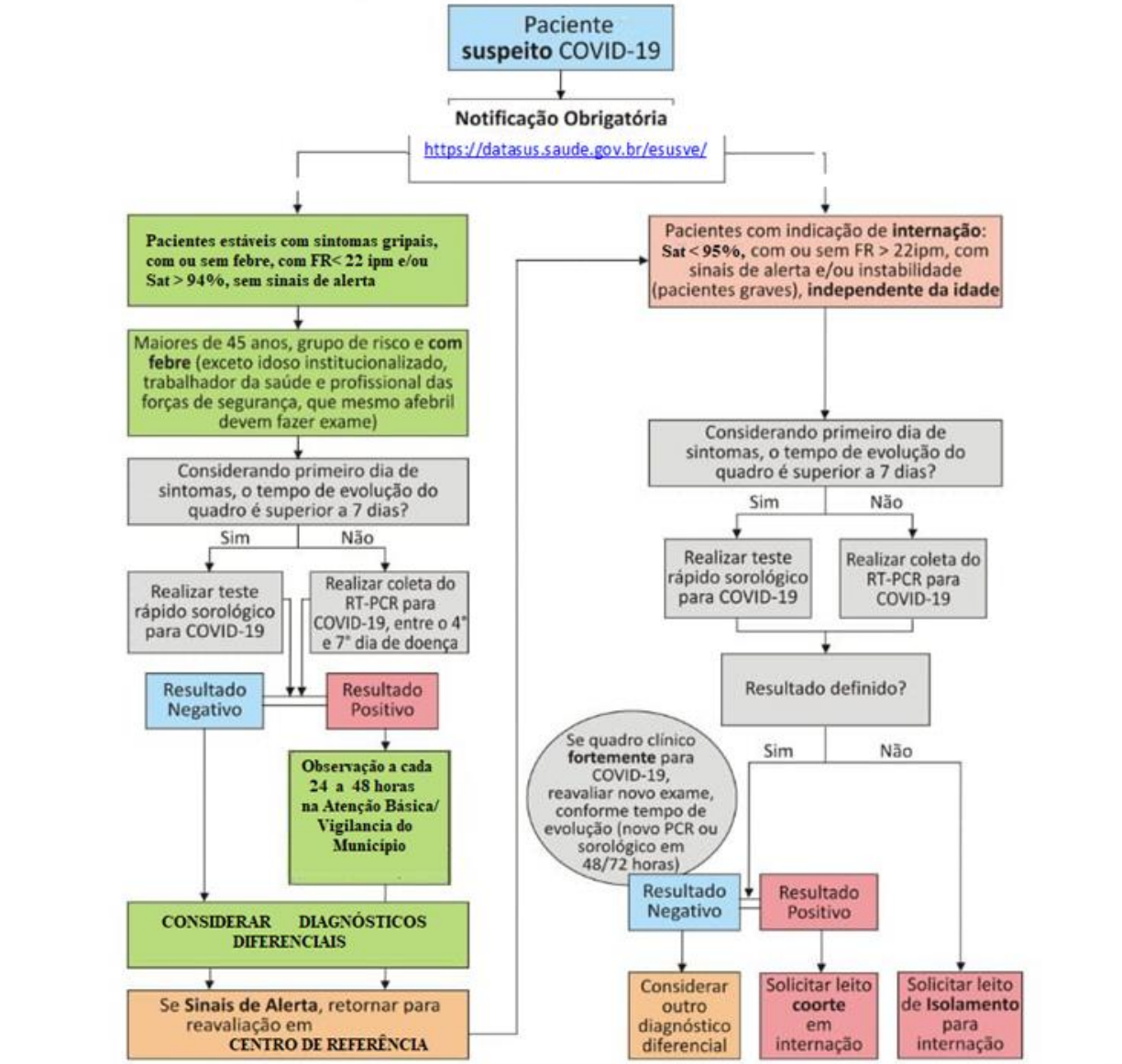
Manejo Clínico

Isolamento domiciliar após a alta, até completar 14 dias após início dos sintomas. Monitoramento por telefone, a cada 24h em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a cada 48h nos demais. Caso seja necessário, realizar atendimento presencial, idealmente no domicílio.

DESFECHO

ANEXO 02

FLUXOGRAMA DE TESTAGEM PARA COVID-19



ATENÇÃO
Sinais de Alerta
Piora dos sintomas, como falta de ar, febre por mais de 3 dias, confusão mental, sensação de pressão baixa e piora da tosse

NÃO possuem indicação
Pacientes menores de 45 anos que estejam assintomáticos e/ou aqueles com história de contato e/ou que possuem quadro clínico para COVID-19 leve, sendo caracterizados como Síndrome Gripal, não havendo necessidade de confirmação laboratorial

DEVEM realizar RT-PCR para COVID-19, independente da idade:

- Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
- Casos suspeitos, com OU sem febre, nestas categorias:

- Hospitalizados
- Trabalhadores da Saúde
- Profissionais das forças de segurança
- Pessoas acima de 60 anos, portadores das comorbidades relacionadas no item 5 - LISTA DE COMORBIDADES
- Idosos em instituições de longa\permanência

- Casos suspeitos COM febre aferida, nestas categorias:

- Gestantes
- Privados de liberdade
- Populacao indigena
- Pessoas entre 45 e 60 anos, portadores das comorbidades relacionadas no item 5 - LISTA DE COMORBIDADES

Secretaria Municipal de Saúde
End: Rua 07 de Setembro nº40,
Centro Administrativo - Jacundá-PA
CEP: 68.590-000
E-mail: saude.jacunda@hotmail.com
Fone: 094 3345-2930 CEL 99119-4385

PODER EXECUTIVO
CNPJ 11.528.843/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 03

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Nº

e-SUS Notifica –04/03/2021

FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SG SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 – COVID-19 (B34.2)

finição de caso: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.
crianças: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.
idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.
servação: Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.

UF de notificação: |_|_|

unicípio de Notificação: _

IDENTIFICAÇÃO

Tem CPF? (Marcar X) |_|Sim |_|Não

trangeiro: (Marcar X) Sim |_|Não

ofissional de saúde (Marcar X) Sim |_|Não

ofissional de segurança (Marcar X) Sim |_|Não

CBO:

PF: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

CNS: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

Nome Completo:

Nome Completo da Mãe:

Data de nascimento: __|_____|____

ís de origem:

Sexo: (Marcar X) |__|Masculino |_|Feminino

ça/COR: (Marcar X) |_|Branca |__|Preta |__|Amarela |__|Parda |__|Indígena Etnia:_____ gnorado

É membro de povo ou comunidade tradicional? (Marcar X) |_| Sim |_|Não

sim, qual?

CEP: |_|_|_|_|-|_|_

ssaporte: |_|_|_|_|_|_|_|_|_

Logradouro:

ımero:

irro:

Complemento:

Estado de residência: |_|_|

unicípio de Residência: _____

Telefone Celular:

lefone de contato:

E-mail:

DADOS CLÍNICOS

Data da Notificação: _|____|___

ta do início dos sintomas: __|___|____

Sintomas: (Marcar X)
|__|Assintomático |__|Febre|__|Dor de Garganta |__|Dispneia |__|Tosse |_| Coriza
|__|Dor de Cabeça |__|Distúrbios gustativos |__|Distúrbios olfativos |__|Outros_____

Condições: (Marcar X)
|__| Doenças respiratórias crônicas descompensadas |__| Diabetes |_| Obesidade
|__| Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5) |_| Imunossupressão
|_| Portador de doenças cromossômicas ou estado de fragilidade imunológica |_| Gestante
|__| Doenças cardíacas crônicas |_| Puérpera (até 45 dias do parto)

Estado do Teste: (Marcar X)
|_|Solicitado
|_|Coletado
|_|Concluído
|_|Exame Não Solicitado

po de Teste: (Marcar X)
RT – PCR
este rápido – anticorpo
este rápido – antígeno
estes sorológico

ta do Teste (PCR/Rápidos):
_|__|___

ta do Teste (Sorológico):
_|__|___

	Resultado (PCR/Rápidos): (Marcar X) |_|Reagente |_|Não Reagente |_|Inconclusivo ou Indeterminado	**ste Sorológico**: (Marcar x) _|IgA _|IgG gM nticorpos Totais	**sultado (IgA):** (Marcar X) Reagente Não Reagente nconclusivo ou Indeterminado
	Resultado (IgG): (Marcar X) |_|Reagente |_|Não Reagente |_|Inconclusivo ou Indeterminado	**sultado (IgM):** (Marcar X) Reagente Não Reagente nconclusivo ou Indeterminado	**sultado (Anticorpos Totais):** rcar X) Reagente Não Reagente nconclusivo ou Indeterminado

NCERRAMENTO	**Evolução do caso:** (Marcar X) |_|Cancelado |__|Ignorado |_|Internado |_|Em tratamento domiciliar |_|Óbito |__|Internado em UTI |_|Cura	**Classificação final:** (Marcar X) |_|Descartado |_|Confirmado Clínico Imagem |_|Confirmado Clínico-Epidemiológico |_|Confirmado Por Critério Clínico |_|Confirmado Laboratorial |_|Síndrome Gripal Não Especificada	**Data de encerramento:**___|___|_____

Informações complementares e observações

PODER EXECUTIVO
CNPJ 11.528.843/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 04

Nº

MINISTÉRIO DA SAÚDE
TARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SIVEP Gripe - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA GRIPE
FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL - CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE HOSPITALIZADO- 23/03/2021

SO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG-HOSPITALIZADO): Indivíduo com *SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto. (*SG: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos). **Para efeito de notificação no Sivep-Gripe, devem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de hospitalização.**

1 Data do preenchimento da ficha de notificação: __/__/__ | Data de 1ºs sintomas __/__/__

3 UF: | unicípio: | ódigo (IBGE): ___|___|___|___|___|___

5 Unidade de Saúde: | ódigo (CNES):___|___|___|___|___|_|___

Dados do Paciente

6 m CPF? (Marcar X) |_|Sim |_| Não | PF:_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

8 trangeiro (Marcar X) |_|Sim |_| Não

9 artão Nacional de Saúde (CNS): __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

10 ome:_ | xo: |_|1- Masc. 2- Fem. 9- Ign

12 ata de nascimento: ___|___|____ | 13 u) Idade: __|__|____ 1-Dia 2-Mês 3-Ano | | | stante: |_| 1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4-Idade Gestacional Ignorada 5-Não

15 aça/Cor: |_| 1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9-Ignorado | ão se aplica 9-Ignorado

16 e indígena, qual etnia?_____

17 membro de povo ou comunidade tradicional? (Marcar X) |_|Sim |_|Não | e sim, qual?_____

19 colaridade: |__| 0-Sem escolaridade/Analfabeto 1-Fundamental 1º ciclo (1ª a 5ª série) 2- Fundamental 2º ciclo (6ª a 9ª série) 3-Médio (1º ao 3º ano) 4-Superior 5-Não se aplica 9-Ignorado

20 cupação: _____ | 21 ome da mãe:_____

Dados de residência

22 EP: __|__|__|__|___-__|__|__

23 F: __|____ | 24 unicípio:_____Código (IBGE): __|__|__|__|__|__|__

25 irro: _____ | 26 gradouro (Rua, Avenida, etc.): _____ | 27 __: ____

28 omplemento (apto, casa, etc...): _____ | 29 DD) Telefone: __|____-__|__|__|__|__|__|__|__|__

30 na: |_|1-Urbana 2-Rural 3-Periurbana 9-Ignorado | 31 aís: (se residente fora do Brasil) _____

Dados Clínicos e

32 ata-se de caso nosocomial (infecção adquirida no hospital)? |_| 1-Sim 2-Não 9-ignorado

33 aciente trabalha ou tem contato direto com aves, suínos, ou outro animal? |_| 1-Sim 2-Não |3- Outro, qual_____9-ignorado

34 ais e Sintomas: 1-Sim 2-Não 9-ignorado |__| Febre |__| Tosse |__| Dor de Garganta |__| Dispneia |_| Desconforto Respiratório |_| Saturação O_2< 95% |_| Diarreia |_| Vômito |_|Dor abdominal |_| Fadiga |_| Perda do olfato |__| Perda do paladar |__|Outros_____

35 ossui fatores de risco/comorbidades? |___| 1-Sim 2-Não 9-Ignorado Se sim, qual(is)? (Marcar X)
|_| Puérpera (até 45 dias do parto) |_| Doença Cardiovascular Crônica |_| Doença Hematológica Crônica
|_| Síndrome de Down |__| Doença Hepática Crônica |_| Asma
|_| Diabetes *mellitus* |__| Doença Neurológica Crônica |_| Outra Pneumopatia Crônica
|_| Imunodeficiência/Imunodepressão |__| Doença Renal Crônica |__| Obesidade, IMC |____|
|_| Outros _____

36 ecebeu vacina COVID-19? 1-Sim 2-Não 9-Ignorado | 37 e recebeu vacina COVID-19, informar: a da 1ª dose:__/__/____ a da 2ª dose:__/__/____

38 boratório Produtor vacina COVID-19: | 39 te da vacina COVID-19: e 1ª Dose_____ e 2ª Dose_____

	40	ecebeu vacina contra Gripe na última mpanha? |_| 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	41	ata da vacinação: _|__|____

Se < 6 meses: a mãe recebeu a vacina? | | 1-Sim 2-Não 9-Ignorado Se sim, data:_____|_____|____ a mãe amamenta a criança? | | 1-Sim 2-Não 9-Ignorado

>= 6 meses e <= 8 anos:

Data da dose única 1/1:___|____|_____(dose única para crianças vacinadas em campanhas de anos anteriores) Data da 1ª dose:_____|___|_____(1ª dose para crianças vacinadas pela primeira vez)

Data da 2ª dose:_____|____|_____(2ª dose para crianças vacinadas pela primeira vez

Dados de Atendimento	42	Usou antiviral para gripe? |__| 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	43	ual antiviral? |_| 1-Oseltamivir anamivir 3-Outro, especifique:_____
	44	ata início do tratamento: ___|___|____		
	45	Houve internação? |_| n 2-Não 9-Ignorado	46	ta da internação por SRAG: _|__
	47	F de internação: __|_____		
	48	Município de internação:_____ Código (IBGE):___|__|__|__|_|__		
	49	Unidade de Saúde de internação:_____ Código (CNES):___|__|__|__|__|_|_		
	50	Internado em UTI? |_| im 2-Não 9-Ignorado	51	ata da entrada na UTI: _|__
	52	ata da saída da UTI: ___|___|____		
	53	o de suporte ventilatório: |_|1-Sim, invasivo 2-Sim, não invasivo 3-Não 9-Ignorado	54	aio X de Tórax: |_| ormal 2-Inflitrado intersticial 3-Consolidação listo 5-Outro:_____ ão realizado 9-Ignorado
	55	ata do Raio X: _|____		
	56	Aspecto Tomografia|__| 1-Tipico covid-19 2- Indeterminado covid-19 3- Atípico covid-19 4-Negativo para Pneumonia utro_____ 6-Não realizado 9-Ignorado	57	ata da tomografia: _|____
	58	Coletou amostra |_| 1-Sim 2-Não 9-Ignorado	59	ata da coleta: _|____
	60	Tipo de amostra: |_| 1-Secreção de Naso-orofaringe 2-Lavado Bronco-alveolar 3-Tecido *post-mortem* 4-Outra, qual?_____5-LCR 9-Ignorado		

Dados Laboratoriais

11 Nº Requisição do GAL: ____

12 Tipo do teste para pesquisa de antígenos virais: |_| 1- Imunofluorescência (IF) 2- Teste rápido antigênico

13 Data do resultado da pesquisa de antígenos: ___|_|____

14 Resultado da Teste antigênico: |_| 1-positivo 2-Negativo 3- Inconclusivo 4-Não realizado 5-Aguardando resultado 9-Ignorado

15 Laboratório que realizou o Teste antigênico: Código (CNES): __|_|_|_|_|_|_

16 Agente Etiológico - Teste antigênico: Positivo para Influenza? |_| 1-Sim 2-Não 9-Ignorado
Se sim, qual influenza? |__| 1- Influenza A 2- Influenza B Positivo para outros vírus? |_| 1-Sim 2-Não 9-Ignorado
Se outros vírus respiratórios qual(is)? (marcar X) |__| SARS-CoV-2 |__| Vírus Sincicial Respiratório |__| Parainfluenza 1 |__| Parainfluenza 2 |__| Parainfluenza 3 |__| Adenovírus |__| Outro vírus respiratório, especifique: _____

17 Resultado da RT- PCR/outro método por Biologia Molecular: |_| 1-Detectável 2-Não Detectável 3-Inconclusivo 4-Não realizado 5-Aguardando resultado 9-Ignorado

18 Data do resultado RT-PCR/outro método por Biologia Molecular: __|____|_____

19 Agente Etiológico - RT-PCR/outro método por Biologia Molecular:
Positivo para Influenza? |___| 1-Sim 2-Não 9-Ignorado Se sim, qual influenza? |_| 1- Influenza A 2- Influenza B
Influenza A, qual subtipo? |___| 1-Influenza A(H1N1)pdm09 2-Influenza A/H3N2 3-Influenza A não subtipado 4-Influenza A não subtipável 5-Inconclusivo 6-Outro, especifique: _____
Influenza B, qual linhagem? |__| 1-Victoria 2-Yamagatha 3-Não realizado 4-Inconclusivo 5-Outro, especifique: ____
Positivo para outros vírus? |___| 1-Sim 2-Não 9-Ignorado Se outros vírus respiratórios, qual(is)? (marcar X)
|__| SARS-CoV-2 |__| Vírus Sincicial Respiratório |__| Parainfluenza 1 |__| Parainfluenza 2 |__| Parainfluenza 3 |__| Parainfluenza 4 |_| Adenovírus
|__| Metapneumovírus |__| Bocavírus |__| Rinovírus |__| Outro vírus respiratório, especifique: _____

20 Laboratório que realizou RT-PCR/outro método por Biologia Molecular: _____ digo (CNES): |_|_|_|_|_|_|_

21 Tipo de amostra sorológica para SARS-Cov-2: |_| 1-Sangue/plasma/soro 2-Outra, qual?_____ 9-Ignorado

22 ata da coleta: _|___|____

23 Tipo de Sorologia para SARS-Cov-2: |_| 1-Teste rápido 2-Elisa 3- Quimiluminescência 4- Outro, qual?_____
Resultado do Teste Sorológico para SARS-CoV-2: |_| IgG |_|IgM |_|IgA
1-Positivo 2-Negativo 3- Inconclusivo 4-Não realizado 5-Aguarda resultado 9 Ignorado

24 Data do resultado: _|___|____

Conclusão

25 Classificação final do caso: |_| 1-SRAG por influenza 2-SRAG por outro vírus respiratório 3-SRAG por outro agente etiológico, qual 4-SRAG não especificado 5-SRAG por covid-19

26 itério de Encerramento:|_| Laboratorial 2- Clínico Epidemiológico Clínico 4- Clínico-Imagem

27 Evolução do Caso:|_| 1- Cura 2-Óbito 3-Óbito por outras Causas 9-Ignorado

28 ata da alta ou óbito: _____|___|____

29 ata do Encerramento: _|_| |____

30 Número D.O: |_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|

31 SERVAÇÕES:

32 ofissional de Saúde Responsável: _____

33 egistro Conselho/Matrícula: __|_|_|_|_|_|_

___

ANEXO 05

TERMO DE DECLARAÇÃO

Eu,_____,RG nº _____, CPF nº_____, residente e domiciliado na _____ Bairro _____, CEP , na cidade de _____, Estado_____, declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr.(a) _____ sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido(a), bem como as pessoas que residem no mesmo endereço ou dos trabalhadores domésticos que exercem atividades no âmbito residencial, com data de início _____, previsão de término _____, local de cumprimento da medida _____.

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de isolamento domiciliar:

1._____

2._____

3._____

4. _____

5._____

Assinatura da pessoa sintomática: _____

Data: _____/_____/_____ Hora: _____: _____

ANEXO 06

Assunto: ORIENTAÇÕES PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES PRIVADOS

Venho por meio deste, solicitar de V. Sª material de USO para ESTE estabelecimento. Para a ação de DESINFECÇÃO/PREVENÇÃO contra o COVID-19.

QUATERNÁRIOS DE AMONIO

MOVADOL- ECOLAB (diluição de até 1:100; diluir 10ml do produto/1 Litro de água)
FONE: (91) 98162-2843 Consultor José Alves
FONE: (94) 98176-0196 Consultor Igor

CLORETO DE BENZALCONIO(diluição de até 1:250; diluir 10ml do produto/2,5 Litros de água)
FONE: (11) 4092-7100 www.powercleaning.ind.br

LETAH MAX (diluição até 1:100; diluir 10ml do produto/1 Litro de água)
FONE: (94) 98176-0196 Consultor Igor

OU

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% que é indicado para desinfecção de superfícies fixas que não contém METAL, por ser um produto corrosivo e de fácil OXIDAÇÃO.

MODO DE USO: Por serem produtos a base de quaternário de amônio, germicida, bactericida e fungicida, apesar de neutros (exceto o hipoclorito de sódio a 1%), recomenda-se a utilização de LUVA(procedimento/emborrachada), MÁSCARA, ÓCULOS, ROUPA HIDRORREPELENTE, GORRO E BOTA EMBORRACHADA. Em casos de contatos com os olhos, lava-los com água em, abundancia, em casos de ingestão acidental, providenciar urgente cuidados médicos.

CUIDADOS NECESSÁRIOS: Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco e NÃO ENXAGUAR superfície após desinfecção.

LEMBRANDO QUE APÓS DESINFECÇÃO DEVEM PERMANECER TODAS AS MEDIDAS PREVENTIVAS JÁ EXPLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUNDÁ.

ANEXO 07

ORIENTAÇÕES QUANTO AO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO

Máscara cirúrgica:

- Usar máscara cirúrgica é uma das medidas de prevenção para limitar a propagação de doenças respiratórias, incluindo o novo coronavírus(2019-nCoV).
- O uso da máscara cirúrgica não é suficiente para fornecer o nível seguro de proteção, outras medidas igualmente relevantes devem ser adotadas (como a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica antes e após a utilização dasmáscaras).
- Usar máscaras quando não indicado pode gerar custos desnecessários e criar uma falsa sensação de segurançaquepodelevara negligenciaroutrasmedidascomopráticasdehigienedasmãos.
- A máscara deve estar apropriadamente ajustada à face para garantir sua eficácia e reduzir o risco de transmissão. Todos os profissionais devem ser orientados sobre como usar, remover, descartá-las e na ação de higiene das mãos antes e após ouso.
- Deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional por gotículas respiratórias, quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 metro do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus(2019-nCoV):
  - Colocar a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e amarre com segurança para minimizar os espaços entre a face e amáscara.
  - Enquanto estiver em uso, evite tocar namáscara.
  - Remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova sempre por trás).
  - Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada deve-se realizar a higiene dasmãos.
  - Substituirasmáscarasporumanovamáscara limpaesecaassimquetornar-seúmida.
  - Não reutilizar máscarasdescartáveis.

Máscaras Faciais de uso não profissional

Assim, máscaras faciais não-hospitalares não fornecem total proteção contra infecções, mas reduzem sua incidência. Especialistas apontam que mesmo pequenas medidas para reduzir transmissões têm grande impacto na atual pandemia, especialmente quando combinadas com medidas preventivas adicionais, que **SÃO ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIAS,** como higienizar as mãos e adotar as medidas de higiene respiratória/etiqueta da tosse: se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos); evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca e realizar a higiene das mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70%. As máscaras de pano feitos com itens domésticos ou feitos em casa com materiais comuns e de baixo custo podem ser usados como uma medida voluntária adicional de saúde pública. As máscaras de uso não profissional não são máscaras cirúrgicas ou respiradores N-95. Esses são suprimentos essenciais que devem continuar reservados para os profissionais de saúde e outros socorristas, conforme recomendado nas orientações atuais do Ministério da Saúde.

ORIENTAÇÕES GERAIS – Máscaras faciais de uso não profissional 3/9 A máscara deve ser feita nas medidas corretas, devendo cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais. Também é importante que a máscara seja utilizada corretamente, não devendo ser manipulada durante o uso e deve-se lavar as mãos antes de sua colocação e após sua retirada. Seguindo as recomendações a seguir, as máscaras faciais de uso não profissional podem ser produzidas em casa, adquiridas no comércio ou diretamente das artesãs.

Usar uma máscara pode ser
***"uma medida adicional de proteção para quem precisa sair", disse Antonio Barra Torres, Diretor Presidente-substituto da Anvisa, é mais uma ação que o cidadão pode fazer, além das demais medidas preventivas*.**"

Indicação/público alvo
Qualquer pessoa pode fazer uso de máscaras faciais de uso não profissional, inclusive crianças e pessoas debilitadas, desde que respeitadas a tolerância, o ajuste e a higiene do material. Recomenda o uso em locais públicos (por exemplo, supermercados, farmácia e no transporte público). O profissional de saúde também poderá indicar a utilização da máscara não profissional nas condições de exposição que ele indicar como adequada.
Quatro regras básicas devem ser seguidas:

a. A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada;

b. Deve-se destinar o material profissional (máscaras cirúrgicas e do tipo N95 ou equivalente) para os devidos interessados: pacientes com a COVID-19, profissionais de saúde e outros profissionais de linha de frente em contato próximo e prolongado com possíveis fontes de contágio;

c. As medidas de higiene e a limpeza das máscaras não profissionais em tecido e a eliminação periódica das descartáveis são ações importantes de combate à transmissão da infecção; e

d. Fazer a adequada higienização das mãos com água e sabonete ou com preparação alcoólica a 70%.

IMPORTANTE: mesmo de máscara, mantenha distância de mais de 1 (um) metro de outra pessoa.

CONTRA-INDICAÇÃO As máscaras faciais de uso não profissional não devem ser utilizadas pelos:

a. profissionais de saúde durante a sua atuação;
b. pacientes contaminados ou suspeitos (com sintomas);
c. pessoas que cuidam de paciente contaminados;
d. crianças menores de 2 anos, em pessoas com problemas respiratórios ou inconscientes, incapacitadas ou incapazes de remover a máscara sem assistência;
e. demais pessoas contraindicados pelo profissional de saúde.

TIPOS DE TECIDOS Para fins de ampliar o acesso é importante que a máscara tenha baixo custo. Recomenda-se, preferencialmente, a utilização de tecidos que contenham algodão em sua composição bem como tecidos sintéticos apropriados, como aqueles definidos na "PR 1002 Prática Recomendada ABNT para máscaras de uso não profissional" e ANFNOR SPEC S76-001. Devem ser evitados os tecidos com potencial de causar irritação ou alergia na pele, e que não propiciem boas condições de conforto ao usuário. Informações quanto a composição dos tecidos:

a.100% Algodão- características finais quanto a gramatura:
I. 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% algodão);
II.120 a 130 (p/ ex, usadas comumente para fazer forro para lingerie); e
III.160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas).
b. Misturas - composição

90% algodão com 10 % elastano;
90 % algodão com 8 % elastano
96% algodão com 4 % elastano.

Forma de uso

É recomendável que cada pessoa tenha entorno de 5 (cinco) máscaras de uso individual

a. Antes de colocar a máscara no rosto deve-se: a. assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas);

b. Fazer a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com preparação álcoólica a 70%/ (cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que se sintam secas);

c. Tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara, deve executar imediatamente a higiene das mãos;

d. Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;

e. Manter o conforto e espaço para a respiração; f. evitar uso de batom ou outra maquiagem ou base durante o uso da máscara.

Advertências

a. Não utilizar a máscara por longo tempo (máximo de 3 horas);

b. Trocar após esse período e sempre que tiver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para respirar;

c. Higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70% ao chegar em ca

d. Retire a máscara e coloque para lavar;

e. Repita os procedimentos de higienização das mãos após a retirada da máscara;

f. não compartilhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada.

Máscara de proteção respiratória (respiradorparticulado):

- Utilizar a máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 micras (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3) quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus(2019-nCoV).
- São exemplos de procedimentos com risco de geração de aerossóis: intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de secreções nasotraqueais ebroncoscopias.
- Trocar a máscara após realização destesprocedimentos.

5. **A máscara de proteção respiratória deverá estar apropriadamente ajustada a face conforme instrução abaixo: Etapas para colocação da PFF no rosto**

- Segurar orespiradorcomapinçanasalpróximoàpontadosdedosdeixandoasalçaspendentes;
- Encaixar o respirador sob oqueixo;
- Posicionar um tirante na nuca e o outro sobre acabeça;
- Ajustar a pinça nasal nonariz;
- Verificar a vedação pelo teste de pressãopositiva.



6. Etapas para retirada da PFF do rosto

a) Segurar e remover o elásticoinferior;

b) Segurar e remover o elásticosuperior;

c) Remover a PFF segurando-a pelos elásticos, sem tocar em sua parte frontal externa, descartando-a em resíduo infectante, após cada contato com opaciente.



Luvas:

Utilizar as luvas de procedimentos não cirúrgicos quando houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo coronavírus (2019-nCoV) para o profissional, assim como, de paciente para paciente por meio das mãos doprofissional.

Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser utilizadas luvas estéreis (de procedimento cirúrgico). Para ambas as finalidades:

- Trocar as luvas sempre que for entrar em contato com outropaciente.
- Trocartambémduranteocontatocomopaciente,seformudardeumsítiocorporalcontaminadopara outro limpo, ou quando esta estiverdanificada.
- Nãotocardesnecessariamentesuperfíciesemateriais(taiscomotelefones,maçanetas,portas)quando estiver comluvas.
- Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem serreutilizadas).
- O uso de luvas não substitui a higiene dasmãos.
- Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada dasluvas.



Protetor ocular ou protetor de face:

- Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubra a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados
- quandohouverriscodeexposiçãodoprofissionalarespingodesangue,secreçõescorporaiseexcreçõe s.
- Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela assistência,devendo,apósouso,sofrerprocessodelimpezacomáguaesabão/detergenteedesinfecçã



1 ANTES DE CONTATO COM O PACIENTE	QUANDO? Higienize as mãos antes de entrar em contato com o paciente. POR QUÊ? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos presentes nas mãos do profissional e que podem causar infecções.
2 ANTES DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ASSÉPTICO	QUANDO? Higienize as mãos imediatamente antes da realização de qualquer procedimento asséptico. POR QUÊ? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos das mãos do profissional para o paciente, incluindo os microrganismos do próprio paciente.
3 APÓS RISCO DE EXPOSIÇÃO A FLUÍDOS CORPORAIS	QUANDO? Higienize as mãos imediatamente após risco de exposição a fluídos corporais (e após a remoção de luvas). POR QUÊ? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência imediatamente próximo ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.
4 APÓS CONTATO COM O PACIENTE	QUANDO? Higienize as mãos após contato com o paciente, com as superfícies e objetos próximos a ele e ao sair do ambiente de assistência ao paciente. POR QUÊ? Para a proteção do profissional e do ambiente à saúde, incluindo as superfícies e os objetos próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do próprio paciente.
5 APÓS CONTATO COM AS ÁREAS PRÓXIMAS AO PACIENTE	QUANDO? Higienize as mãos após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas proximidades do paciente - mesmo sem ter tido contato com o paciente. POR QUÊ? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo superfícies e objetos imediatamente próximas ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.

o.S

- Sugere-separaadesinfecçãocomhipocloritodesódioououtrodesinfetanterecomendadopelofabricante do equipamento deproteção.

7. Capote/ avental:

- O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos onde há risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a contaminação da pele e roupa do profissional.
- Ocapoteouaventaldeveserdemangaslongas,punhodemalhaouelásticoeaberturaposterior.
- O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado após a realização do procedimento e antes de sair do quarto do paciente ou da área deassistência.
- Após a remoção do capote deve-se proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o profissional, paciente eambiente.

8.
9.
10. Higiene das mãos
11. profissionais de saúde devem realizar a higiene das mãos, de acordo com os 5 momentos para a higiene das mãos em serviços de saúde

:Higiene das mãos com água e sabonete líquido

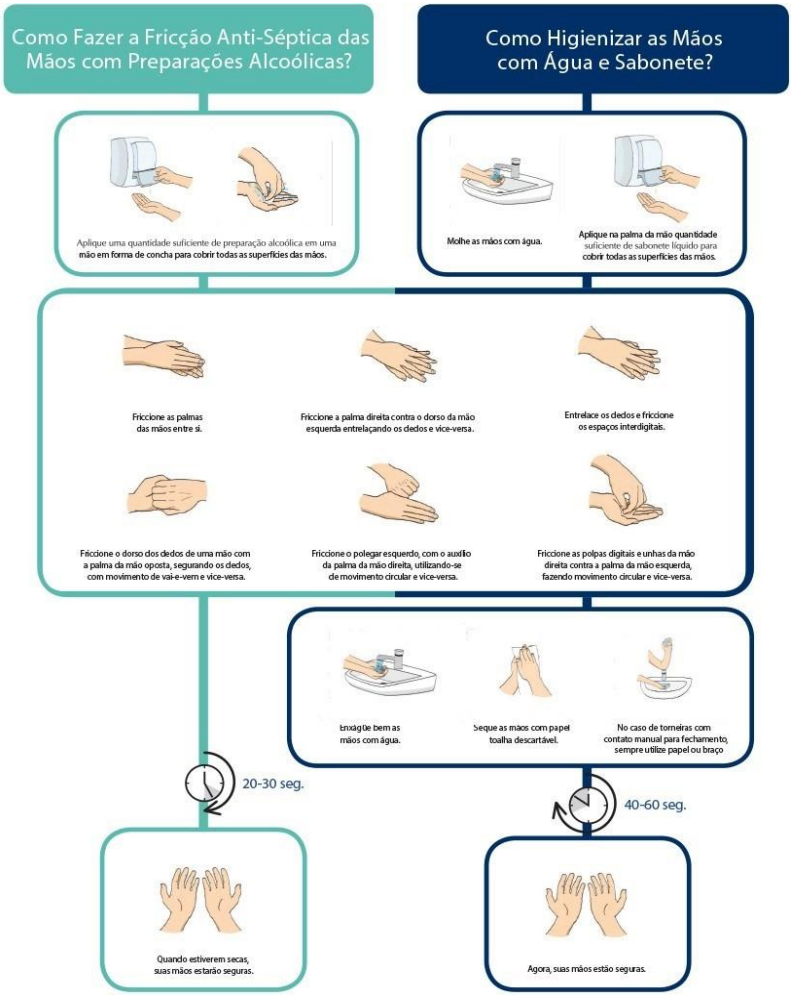
- Antes e após o contato direto com pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus (2019-nCoV), seus pertences e ambiente próximo, bem como na entrada e na saída de áreas com pacientes infectados.
- Imediatamente após retirar asluvas.

- Imediatamenteapóscontatocomsangue,fluidoscorpóreos,secreções,excreçõesouobjetos contaminados.
- Entre procedimentos em um mesmo paciente, para prevenir a transmissão cruzada entre diferentes sítios corporais.
- Em qualquer outra situação onde seja indicada a higiene das mãos paraevitar
- Ahigienedasmãoscom águaesabonetelíquidoéessencialquandoasmãosestãovisivelmentesujasou contaminadas com sangue ou outros fluidoscorporais.

Higiene das mãos com preparação alcoólica

- Antes de contato com opaciente;
- Após contato com opaciente;
- Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivosinvasivos;
- Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparocirúrgico;
- Após risco de exposição a fluidoscorporais;
- Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante a assistência aopaciente;
- Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas aopaciente;
- Antes e após a remoção deluvas;

  Devem-se higienizar as mãos com preparação alcoólica (sob as formas gel ou solução) quando estas **NÃO** estiverem visivelmente sujas.



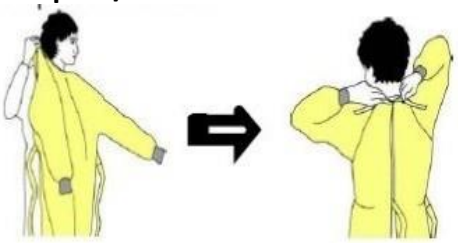
Descrição sequencial de como deve ser realizada a paramentação

pelosprofissionaisSequência para colocar osEPIs:

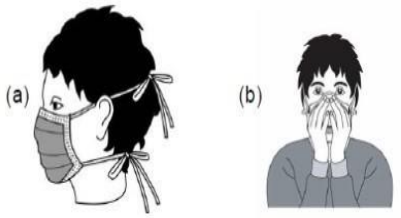
Colocar a paramentação à porta antes de ter contato com o paciente.

12.

13. Capote/avental:



Colocar máscara cirúrgica ou máscara N95:



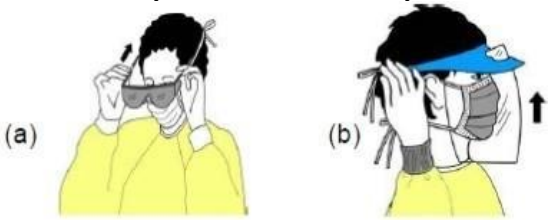
- Adapte a haste flexível ao nariz (ponta do nariz);
- Adapte a máscara à face e abaixo do queixo;
- Confira a adaptação do respirador/máscara.

Seguir rigorosamente as orientações disponíveis no item específico sobre uso de máscara N95;

O profissional deve utilizar a máscara sempre que entrarem na área de isolamento onde se encontra o paciente, se realizar procedimentos geradores de aerossóis, descartar a máscara logo após realização do procedimento e fazer uso de uma nova máscara.

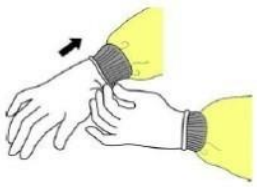
14.

15. Colocar protetor ocular ou protetor de face:



Fazer uso de gorro para procedimento maior risco.

calçar as luvas conforme tipo de procedimento:



- Use luvas não estéreis para isolamento e precaução;
- Selecione as luvas de acordo com o tamanho da mão;
- Ao calçar a luva estenda-a até cobrir o punho do avental de precauções.

Conforme orientações da Secretaria do Estado do Pará, recomenda-se, utilizar duas luvas de procedimento.

16.

Sequência para retirada dos EPIs:

Remover a paramentação à porta antes de deixar a sala ou o quarto do paciente ou na ante sala do quarto se houver.

1. Luvas

A primeira luva deverá ser retirada e descartada no quarto e a segunda luva na antessala.



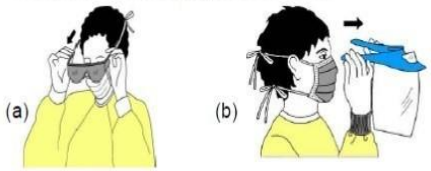
- Segure o lado de fora da luva com a mão oposta enluvada e remova-a.
- Segure a luva removida com a mão não enluvada.
- Introduza os dedos da mão não enluvada no punho da luva e remova-a de dentro para fora.

2. Capote ou Avental
- Higienizar as mãos após retirar o capote ou avental



- Solte o laço do pescoço e depois o da cintura.
- Remova o avental de dentro para fora, sem tocar o exterior.
- Após removê-lo, descarte-o na lixeira ou Hamper no caso de ser reprocessado.

3. Gorro (se utilizado)
4. Protetor ocular ou (b) Protetor facial



- O lado externo dos óculos é contaminado.
- Para removê-los, segure-o pelas pernas.
- Coloque no recipiente para reprocessamento.

5. (a) Máscara cirúrgica ou (b) Máscara PFF-2, N-95 ou similar
- Evitar tocar a área externa da máscara - descartar
- Higienizar as mãos após desprezar a máscara



- Puxe apenas as alças inferiores e após as superiores e remova.
- Descarte na lixeira.